2026 R1 Survival Guide

科內基礎資訊

- 白天顧病房：桃分3A or 5A (慢性病房)：林口5G (亞急性) = 3：1
  - 林口 (上班時間 7:30-17:00)：10-12床＋跟光哥team查房(cover該team PGY off＋值班沒有off)
  - 桃分 (上班時間 8:30-16:30) ：無特休時：每個R1跟2-3位VS，每一位VS原則上最多16位病患。5A CR 可到38+床（若那層只有一位R1），有NP或R特休時就比較浮動：25-45床（8月分team會有大變動，一切尚不明瞭）
    → 原則：

    (1)每層樓總床數110床。一位NP至多接24床，超過則由R1負責(即: 110- NP#*24=R1要顧的病人數量)。

    (2) From ADD to DC: 如果NP的病患出院，總顧床數<24，就是等新的入院補到上限，外圍在你手上的不會因此還給NP，要顧到出院。進出院很難預期。5A若林口來的才有辦法自己分配。不然很常A醫師病患出院，補B醫師的病患。系統就是想辦法把病房塞滿，照待床名單，不會去看各醫師平衡。
- 晚上值班：桃分3A+5A一線 (16:30-08:30＋16:00以後[根據上護理紀錄的時間]的new pa)，隔天PM off (11:30下班，接11:00之前的new pa)
- Meeting：

  1、 林口：

  a. 星期三早上07:30 林口學術大晨會，除了禮拜二桃分值班的人，其餘人全部都要參加

     ★ 但若遇到當月輪訓林口的住院醫師禮拜二在桃分值班，則請同屆協調一位早上至桃分接班

  b. 學術大晨會結束後，同日早上08:00為林口行政科會，當月輪訓「林口」的住院醫師要擔任紀錄，其他輪訓桃分的可先離開回桃分上班

  c. 星期五中午12:00為林口學術科會、12:30為林口行政科會，當月於林口的R要參加，其他人不用

  2、 桃園：星期五中午12:30桃分科會，當月於桃分要參加，林口的人就參加林口科會即可
- 光哥MSK讀書會：每月一次於第二周周四17:00開始，通常在林口大討論室 (林口的R1負責訂飲料，R+光哥約17杯，要訂有可以咬的品項，光哥的贊助放在一個公文資料夾，每月傳承）
- 週二7:30住院醫師線上讀書會
- 報告：考古題詳解、週二讀書會*2、林口早療、桃分早療、林口晨會、台北晨會、桃分跨領域、年會口頭報告…… 約一個月一至兩個

住院復健

- 住院兩三事：

1、 住院時間:

A. 桃分:

(1) 住院長度:

✔ **onset**一年內:**5-6**周 (只要不確定就跟主治醫師確認)

★ 特例:翔寧醫師只收一年內, 住**4-5**周;韶芝醫師一年內的, 住**5**周

★小技巧:一開始不要講太死住滿6週, 留點餘裕

✔ onset一年以上:須開立自費項目才可以住院 (如rTMS、IV laser、機械手/腳、體適能、音樂治療、藝術治療、Botox注射等等), 住院長度以4週為主

★ 特例:靖倫醫師的住院時間很彈性, 可以請病人跟主任談好, 再跟主任確認

★ 具體周數主治醫師有最終決定權, 針對特殊病人可能有對應調整

✔ 快滿一年的病人, 只能住到滿一年的前一天, 不管幾周!!(可以先跟主治醫師確認, 有的主治醫師會同意直接當超過一年做自費住四周)

e.g. 診斷:1. Right middle cerebral artery(MCA) M2 occlusion, with right hemisphere infarction, s/p endovascular thrombectomy(EVT) with TICI:2b, NIHSS:20, onset: 2025/10/26 13:00, with …. → 2026/10/**25** 滿一年

B. 林口:

(1) 住院長度:有以下兩種計算方式

✔ 轉入復健科起 4-6週(按照病房政策及待床人數滾動式調整)

✔ 入住「長庚醫院」起的總住院天數不得超過「**60**天」(若上游病人待床人數較少, 以林口**CR**當月宣布為主)

2、 口才訓練班——病情解釋:

A. Onset後一年內可以健保身份做復健, 但復健為階段性復健, 並非在一間醫院從頭住到尾, 每間醫院可住長度不一, 需自行和該醫院討論 (再次強調我們不能代其他醫院做回覆！)

B. 因每間醫院床位狀況可能有所浮動, 建議在住院日到期最少前**3**周討論未來動向**(**可以一開始轉來就先跟家屬討論有沒有規劃！不然後續不一定遇得到家屬**)**, 甚至提早排床, 若對方醫院提早通知床位建議就直接去了, 而不是等到長庚到期才去, 屆時對方可能就沒床了

C. ***出院動向*** **1.**回家 **2.**轉院 **(**基隆 **/** 土城 **/** 他院**)** **3.**自費中醫病房 **4.**機構

(1) 回家

- 掛兩周內的回診, 評估是否可再次入院復健 (間隔最少15天, 通常約3~6周可以再排進來)
- 大部分復健科的病人, 都是病情穩定有辦法回家的!!! (家屬說沒辦法回家, 大多是因為上下樓梯不方便、家裡沒有設備…但其實都不是理由, 因為都是老問題)
- 因家裡不方便回不去, 可建議病人選擇住旅館

- 有管路:若回家時間有可能**>1**個月，需要在家更換管路，出院前約**7~10**天會診出院準備服務，並開立居家照護醫囑單
  - 請正確填寫所有資訊，不然會被退件
  - 印出後中間和最下面需要簽名（其中一處要寫身份證字號）和蓋醫師章
- 確定之後不住院復健:可評估是否符合長照**2.0** (聯絡轉介學姐評估，一樣出院7~10天前會診，記得提醒病人早點決定)
  - 轉介學姐還會需要一份病摘

(2) 轉院

重要:不論想轉去哪都要先跟病人及家屬說住院時間到還沒等到就要回家等！！

✔ 林口:可安排轉院至桃園長庚（和CR討論後開立、排除困難病人）、土城長庚（請在群組跟CR說）、基隆長庚（請在群組跟CR說）或自行至外院掛號排床

- Tips:
  - 一開始不可以跟病人或家屬保證桃分可以收治（要讓對方知道我們是節省對方跑一趟門診評估的時間，不是保證可收，以免產生糾紛），建議觀察病人與照顧者的病況和配合度，再決定開立
  - 土城長庚/基隆長庚:見下方

✔ 桃園:

⇨ 基隆長庚 **(**情人湖院區**!)** – 在teamplus群組「桃分復健病房宣達群組」告知CR預排床之病人，由基隆端決定是否收治，若對方同意，則協助開立住院單，請病人 / 家屬簽署後交去住院櫃檯，接著就靜待通知

- Tips:
  - 所以一開始不可以跟病人或家屬保證基隆可以收治！（可以說:我可以幫你問問看，但還是要看那邊有沒有辦法收）
  - 基隆收病人標準嚴格，若有眼科、牙科、ENT需求不收;病情不穩定、洗腎（需去門診詢問）、poor M6、data不漂亮可能會不收
  - 因此在詢問**CR**轉基隆前，最好確認病人狀況穩定，**note**修改過，才不會被擋一來一回浪費時間
  - 對方若回覆 “請至主治醫師門診評估”還是有機會，請家屬直接去情人湖自費掛號，帶著病人的影片或是開啟視訊，門診VS直接評估
  - 目前要等超過**4**週

⇨ 土城長庚 – 一樣在teamplus群組「桃分復健病房宣達群組」跟CR說，但由於土城是young V 值一線班，收治標準更嚴格，一定要沒有管路、病況穩定、**M6 status**，最好是能走來走去才能詢問土城

- Tips:
  - 土城床位極少，待床時間難預估 (可能超過三個月)，建議病人如果想積極住院復健不要**all in**土城，一定要有備案
  - 簽給 2138 鍾維勵醫師和 2491 曾章杰醫師

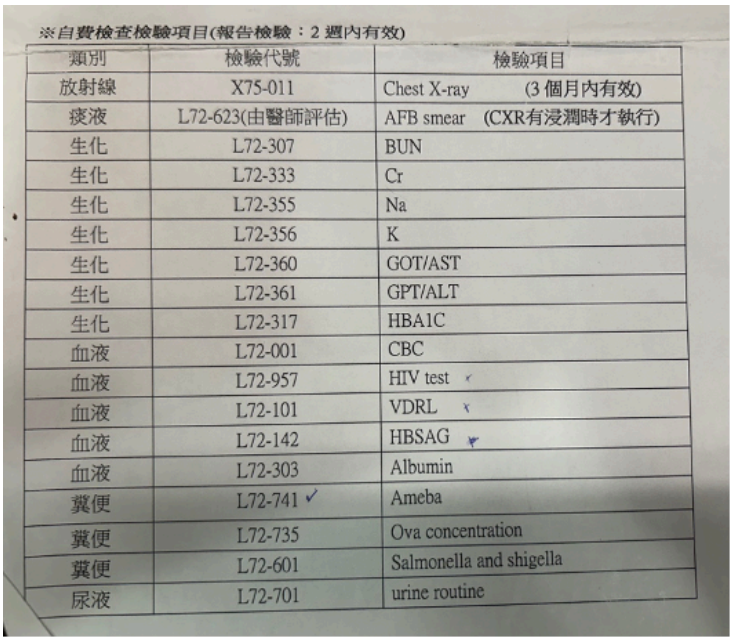
⇨ 其他醫院:德仁、樂生、桃榮、署桃、新國民、華陽、或是台北的各大醫院，每間醫院的收治標準不一樣，有些不收有管路，有些只收半年內，我們無法幫忙，需開立病歷摘要，請家屬至他院復健科門診＊＊＊自費看診＊＊＊ (因病人住院中，無法使用健保門診，但可以跟書記借健保卡作為身分證明)，由他院醫師評估是否收治。(桃分護理部出院準備網頁有北部復健醫院清單可參考、大部分電腦的桌面也有)(路徑:常用功能-部門網頁-護理部-右上角下拉式選單-出院準備-長期照護資源)

★ 病人由林口轉至桃分 (地區醫院)後，不可再轉回林口長庚 **(醫學中心)**做復健，除非特殊事件 (例如recurrent stroke)

★ 病人常常會問，去其他醫院後還可不可以回來桃園長庚，答案是可以～若在情人湖院區，則請基隆端幫忙開住院單，去外院的則需回診請主治醫師評估，但請切記，每次住院間隔至少需滿**15**天，才可再次入院 **!!!!**

★ 林口轉到桃分或是桃分轉至基隆/土城，請開立「一天份」藥量，若轉至外院可詢問病人是否需要幫忙掛我們的門診，開藥到下次回診(避免外院沒有藥物)

(3) 照護機構:如果之後不再住院做復健，要送機構的時候，可請轉介學姐幫忙詢問，長庚體系有分院附近的長青護家，或桃分**6F**護理之家可以去，轉介學姐可提供其他地區的護理之家名單，或是院內網路上有，但需家屬自行聯絡！確定動向後，開立機構入住前的「自費」體檢 **(有些要好幾天才會出來，建議留7~10天!!)**，完成後準備轉出。



※自費檢查檢驗項目(報告檢驗：2 週內有效)

類別	檢驗代號	檢驗項目
放射線	X75-011	Chest X-ray (3 個月內有效)
痰液	L72-623(由醫師評估)	AFB smear (CXR有浸潤時才執行)
生化	L72-307	BUN
生化	L72-333	Cr
生化	L72-355	Na
生化	L72-356	K
生化	L72-360	GOT/AST
生化	L72-361	GPT/ALT
生化	L72-317	HBA1C
血液	L72-001	CBC
血液	L72-957	HIV test
血液	L72-101	VDRL
血液	L72-142	HBSAG
血液	L72-303	Albumin
糞便	L72-741 ✓	Ameba
糞便	L72-735	Ova concentration
糞便	L72-601	Salmonella and shigella
尿液	L72-701	urine routine

(4) 8F中醫全自費病房

- 若病人經濟狀況允許可以自費 (病房費3人房一天約2千，2人房約5千，單人房6千，確切費用可以詢問中醫)，可以去樓上中醫病房等床，當作等外院的銜接。
- 在中醫病房一定要接受中醫治療 (中藥或針灸)，若只吃中藥就會診中醫內兒科takeover，若可以針灸就會診中醫針傷科takeover，等床時間要詢問中醫看會診的住院醫師
- 中醫病房所有東西都自費，包含量vital signs、抽血做檢查，復健也是全自費 (病人會變成門診復健身分，復健會排超久，要跟病人說須有心理準備，若住的時間短，甚至可能排不到復健；每「天」復健 PT OT ST 每個需要600多至800多不等，因此加起來就要2000~3000元)
- 去中醫病房視為出院，因此幫忙掛復健科回診，帶藥帶到回診當天

總結

★ 動向要提早問，越快開始討論越好，住院4周一定要有答案，翔寧醫師的病人最好第1周就確定動向。不要留快到期的動向給交班的下一位！

★ 大多數病人都是轉院 (一般是基隆，有特別需要離家近會去排外院) 或是回家，狀況極好可以詢問土城，但是一定要有備案 (等不到就回家、或是去住飯店也是備案)

★ 大於一年的病人，一定是回家或是去中醫病房 (病人通常自己也知道動向)

★ 狀況較差的病人，若他院不收，通常去機構或是中醫病房

★ 多留幾個備案絕對是好事，大不了取消不要去

★ 若病人已經狗急跳牆要到deadline了還走投無路，則可考慮

- 回家等床：畢竟病人最終都要回家…回家準備也是要做的
- 中醫病房：浮動大，通常要等2-3周
- 真的超過45天也不是世界末日，就是超長期住院，主治醫師可能會一直找你

- 病人照顧:

1、 病歷:

A. 不管在哪邊，住院當天都須完成admission note ～ 桃分請多送一個special procedure note，在內文中打上診斷＋復健評估 (林口是acceptance note)

★ 因應評鑑需求，每個病人的admission和progress note皆需輸入measurable goals (功能選單 - 病歷記載 - 住院診療計畫書 or 直接拿桌面範本改)

B. 每天病歷的O皆有不同要求:

一	二	三	四	五
Rehabilitation assessment	PE	Barthel index	復健紀錄	Weekly summary, 需在brief history放上復健評估

C. 桃分額外規定

(1) 每周其中兩天要貼上全人照護(尤其是黃金病歷，要評鑑的非常時期)

(2) 床邊復健運動類別:1.2.3/3.4.5 (一次盡量不超過3項)



(3) 自主訓練標準-紅色/藍色/綠色

手圈註記顏色	標準
紅色	不可練走
藍色	使用輔具在照顧者陪同下可以練走
綠色	在照顧者攙扶陪伴下練走

D. 星期六病歷:

(1) 林口:5G由值班PGY以自己帳號完成，外圍 (6H) 由值班R2完成

(2) 桃園:值班不打！星期一由當科住院醫師 / **NP**補，原則上需以progress note的形式完成，記得要改成禮拜六的vital signs

E. 星期日病歷:桃園請**R1**、林口請R2值班人員以當天值班的**VS**帳號完成**holiday note**，主訴需改成「**impaired activities of daily living function**」

★ 桃分值班主治為G2、林口為H2，帳密請見line交班群組

★ 星期日病歷請「下午」**2-3**點過後再打！！！因為主治醫師需要在24小時內完成簽章，不然會被通緝！

★ 診斷如果出現空包彈，需貼上，不要空白

F. 分段結清：若遇病人身份改變 (重大到期)或是住太久，會遇到分段結清，這種病人在系統上會原地跳成新病人(即使他可能在你手上住了N天)，請點選病歷記載→分段結清病摘輸入，選擇正確的住院時間段落，完成病歷記載，動向點選持續住院。桃園打完就好不用多做任何事，但林口需要印出交給書記（他們會提醒你）。

G. 5A CR 理論上「每天」都要點「5A 各主治醫師」至少「一位」病人的交接班，但變成38床後有點困難做到，試試看每週點一次...

★ 路徑：功能選單-交接班-交班紀錄

功能選單-交接班-接班紀錄-在接班處理情形打ok

功能選單-交接班-總醫師確認-在總醫師確認打ok

2、 病歷中的診斷

A. 原則：診斷、Onset、經過處置、功能性診斷、評估量表

B. 不可寫「縮寫」

C. 範例們：

(1) 中風們：

✔ Left middle cerebral artery territory infarction and left internal carotid artery total occlusion, onset on 2019/05/21, with right hemiplegia, aphasia and dysphagia, modified Rankin scale: 4

✔ Right thalamic hemorrhage, onset on 2019/01/02, status post craniotomy for hematoma removal on 2019/01/03, with sequelae of left hemiplegia, modified Rankin scale: 3

(2) 脊隨損傷：

✔ Spinal cord injury with C4-7 herniated intervertebral disc, onset on 2019/05/11, status post C4-7 anterior cervical microdiscectomy and interbody fusion and internal fixation on 2019/05/17, Neurologic level of injury: above C5, with tetraparesis, central cord syndrome type

✔ Spinal cord injury, onset on 2019/06/01, with C3-5 herniated intervertebral disc, C5-6 ruptured disc, spinal compression and myelopathy, status post C3-6 anterior discectomy and interbody fusion with PEEK cage on 2019/06/01, with tetraplegia, Neurologic level of injury: C6, American Spinal Injury Association impairment scale: C

(3) TBI：

✔ Traumatic brain injury with right fronto-temporo-parietal subdural hemorrhage, onset on 2018/11/21, status post craniectomy on 2018/11/21, status post

cranioplasty on 2019/02/19, with left hemiplegia, dysphagia, Rancho Los Amigos level: IV

- ✔ Traumatic brain injury, onset on 2019/03/20, with left sylvian fissure subarachnoid hemorrhage and right subdural hemorrhage, with left hemiplegia, Rancho Los Amigos level: VII

3、 上傳外院病歷和影像

A. 填寫「病歷掃描申請單」和/或「X光片掃描申請單」(不用太認真寫！)

B. 外院資料和申請單一起交給護理師

C. 病歷查詢路徑:病歷總覽-健康照護-外來病歷, 影像就會在PACS裡面

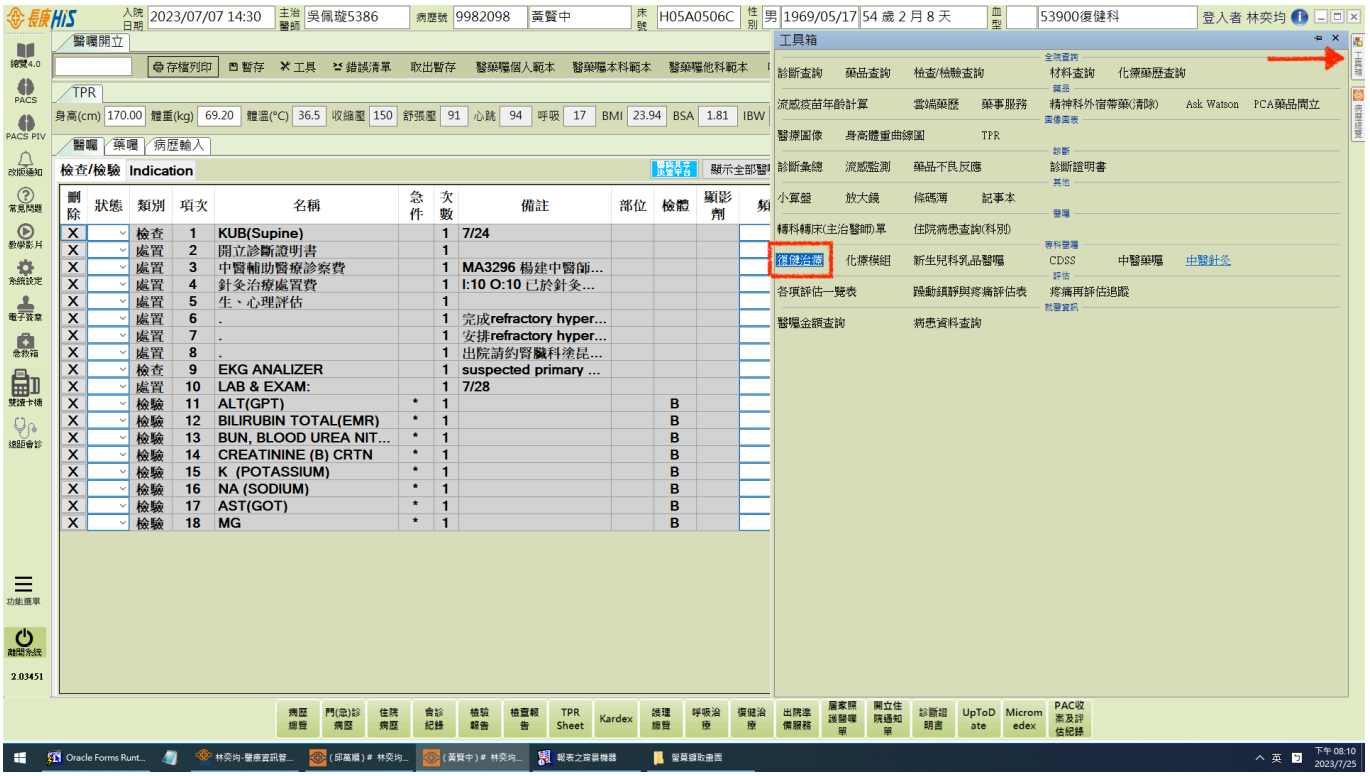
4、 KPI

每月初 3A CR會提醒大家計算上個月主治醫師的KPI, 請個別叫出當月跟的主治醫師「醫師別出院病患」, 月份填前一個月, 印出 A5 大小的 list 之後, 一個一個病歷號去確認中風病患們是否有在使用抗血小板或是抗凝血用藥, 計算出百分比, 再拍照上傳「桃分復健病房宣達群組」

- 復健治療開立:

1、 復健項目:林口與桃分的復健項目位置不同，要看清楚再點否則會被復健櫃台打電話追殺

A. Order:工具箱 - 復健治療 - 點擊完成後請代入 - 關閉復健治療 - 存檔



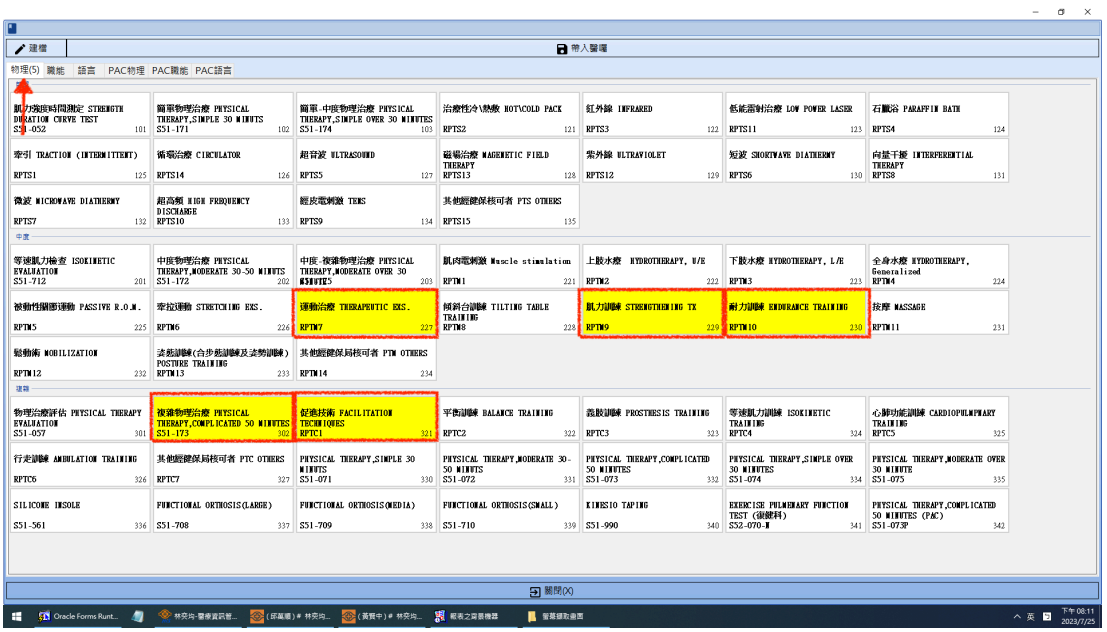
項目開立:

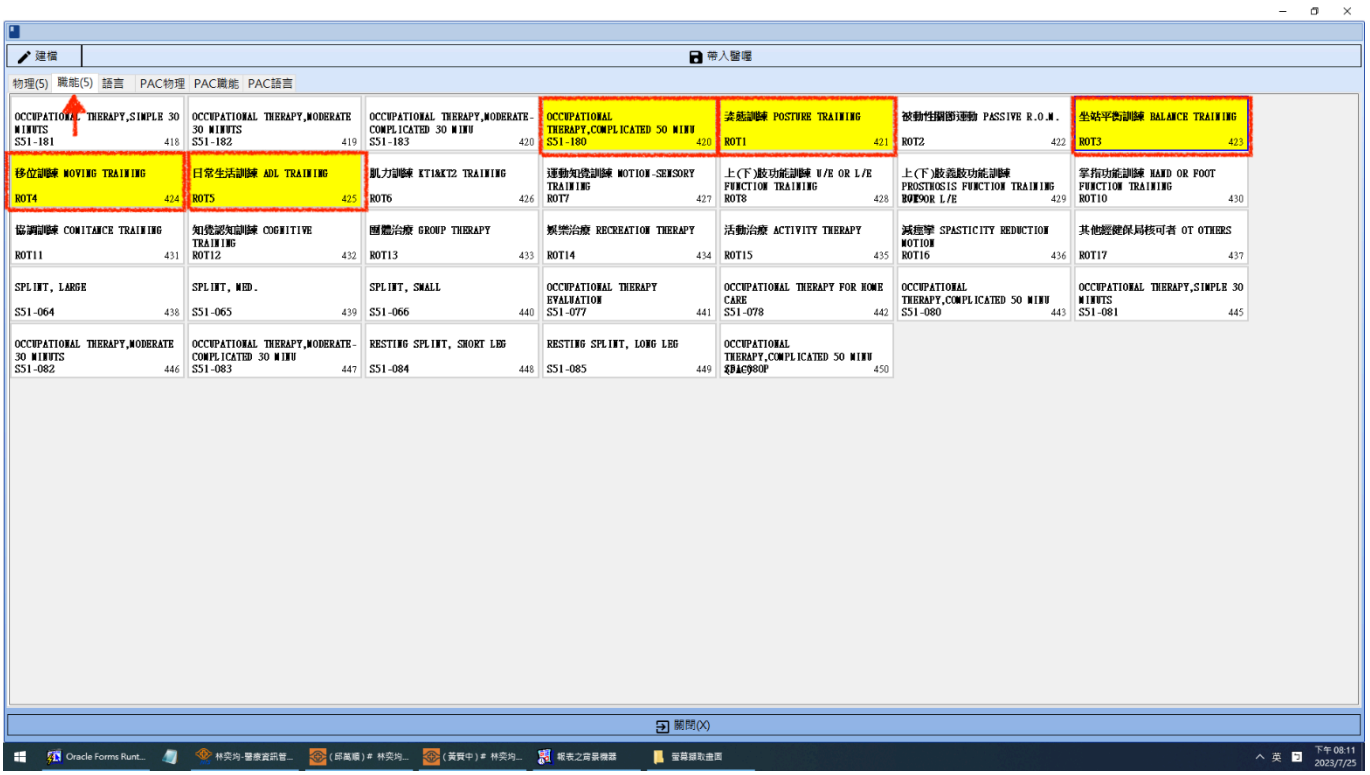
★ 若無ST需求，可直接略過，開立相對應的PT、OT即可(如不確定可詢問CR)

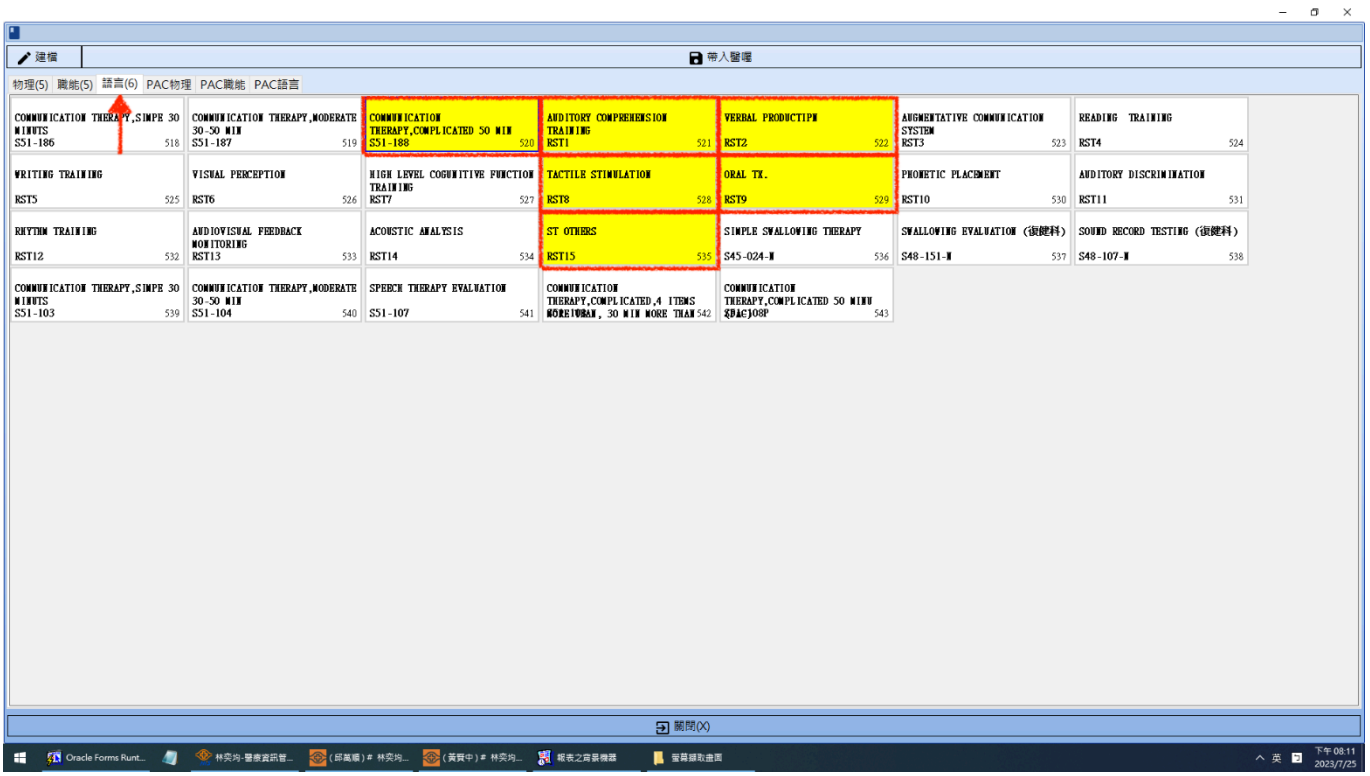
★ 較特殊的還有PAC，開立項目較特別，後面有詳細說明

★ 有醫囑範本可以參考

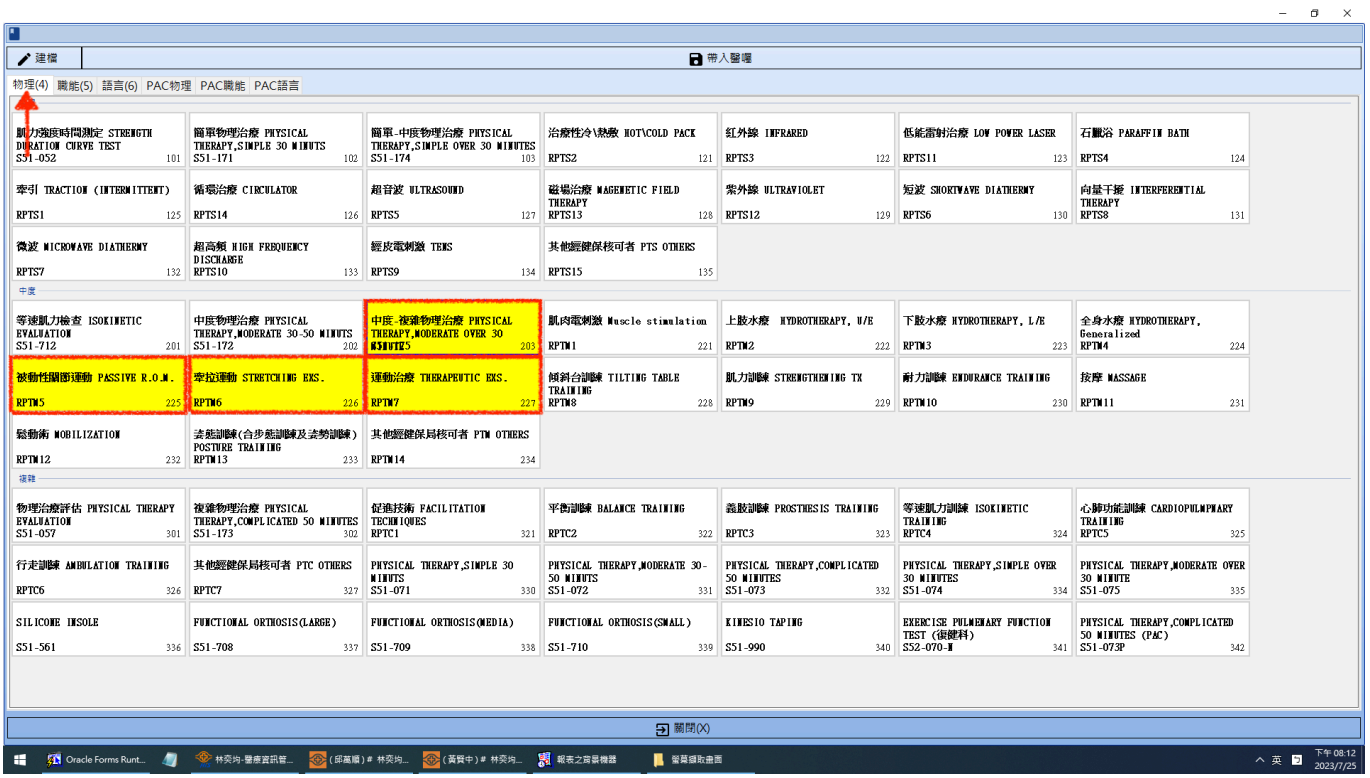
(1) Onset一年內:請開立「複雜」復健，PT / OT / ST:5 / 5 / 6（含complicated 50min therapy）

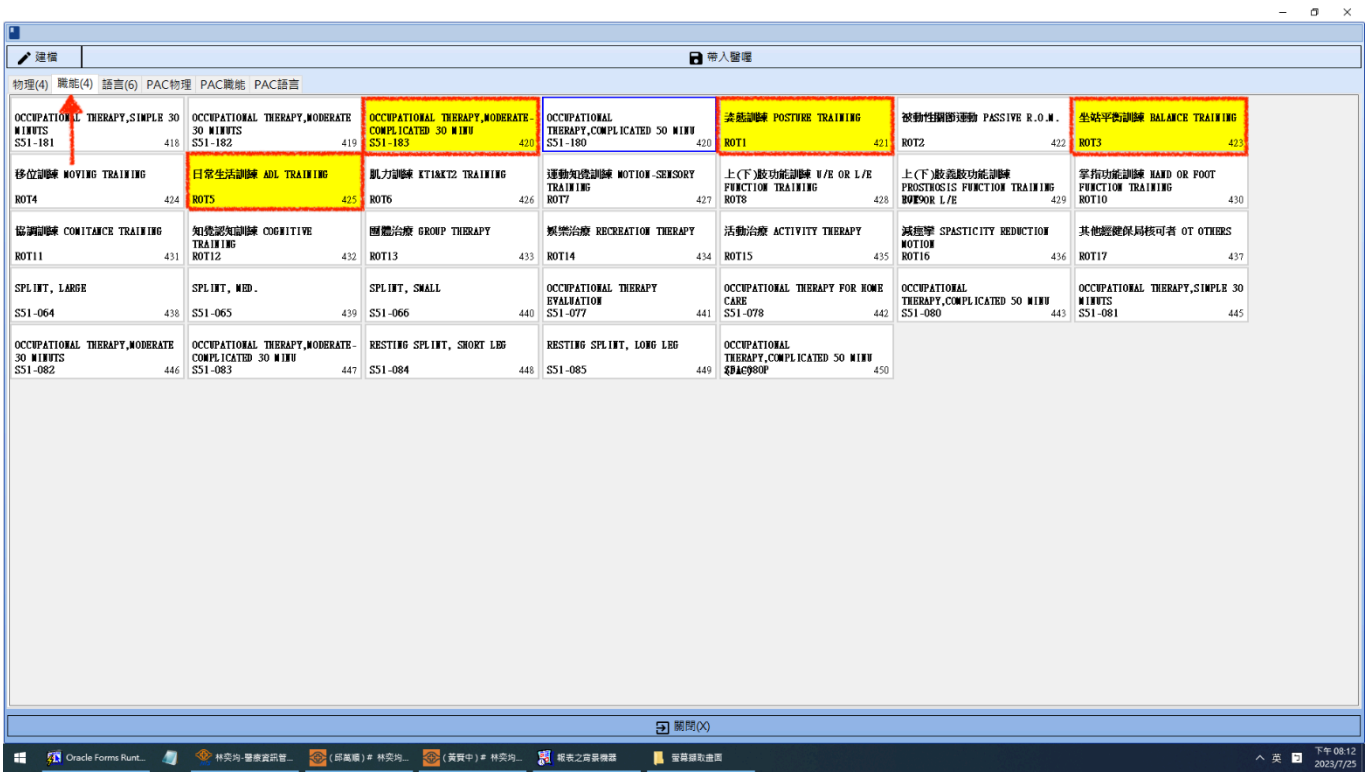


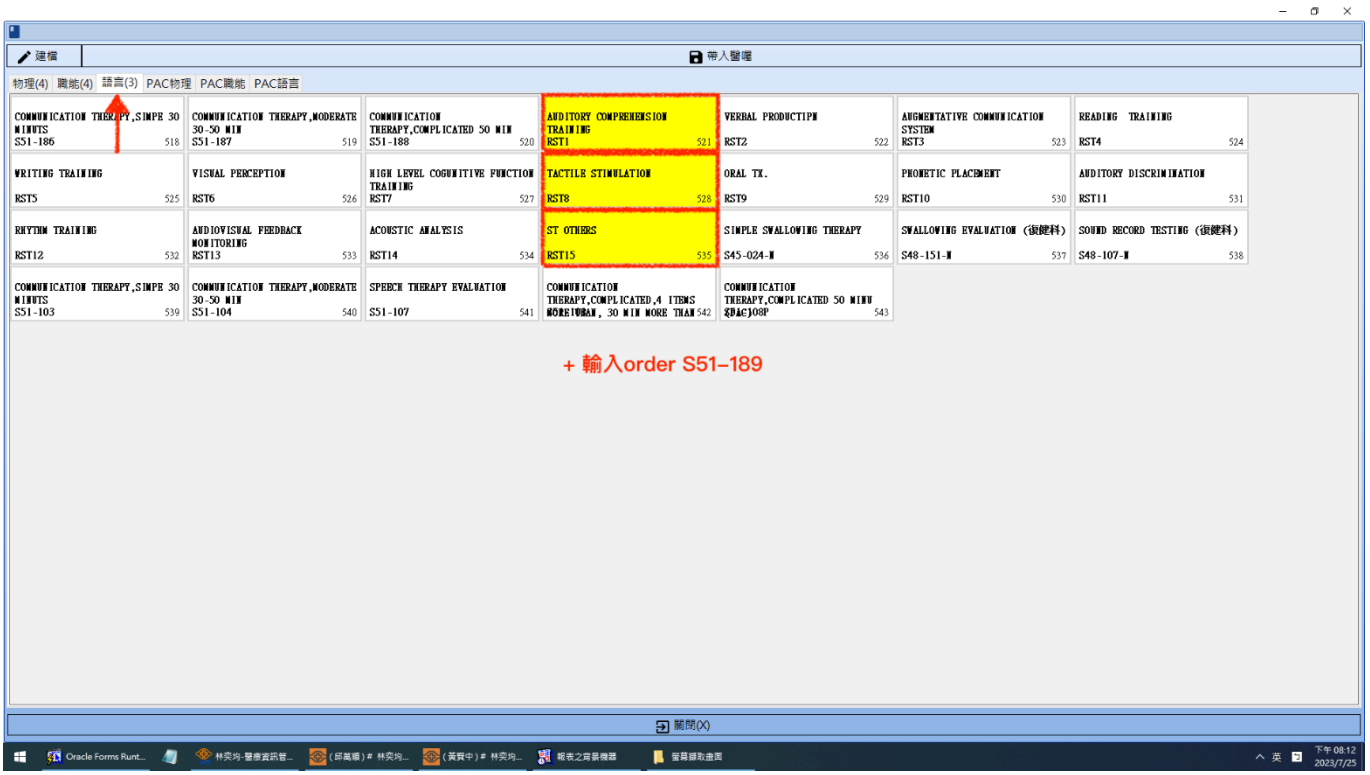

建檔
帶入醫囑
物理(5) 職能(5) 語言 PAC物理 PAC職能 PAC語言
OCCUPATIONAL THERAPY,SIMPLE 30 MINUTS S51-181 418
OCCUPATIONAL THERAPY,MODERATE 30 MINUTS S51-182 419
OCCUPATIONAL THERAPY,MODERATE-COMPLICATED 30 MINU S51-183 420
OCCUPATIONAL THERAPY,COMPLICATED 50 MINU S51-180 420
姿態訓練 POSTURE TRAINING ROT1 421
被動性關節運動 PASSIVE R.O.M. ROT2 422
坐站平衡訓練 BALANCE TRAINING ROT3 423
移位訓練 MOVING TRAINING ROT4 424
日常生活訓練 ADL TRAINING ROT5 425
肌力訓練 KT1&KT2 TRAINING ROT6 426
運動知覺訓練 MOTION-SENSORY TRAINING ROT7 427
上(下)肢功能訓練 U/E OR L/E FUNCTION TRAINING ROT8 428
上(下)肢義肢功能訓練 PROSTHOSIS FUNCTION TRAINING ROT9OR L/E 429
掌指功能訓練 HAND OR FOOT FUNCTION TRAINING ROT10 430
協調訓練 COMITANCE TRAINING ROT11 431
知覺認知訓練 COGNITIVE TRAINING ROT12 432
團體治療 GROUP THERAPY ROT13 433
娛樂治療 RECREATION THERAPY ROT14 434
活動治療 ACTIVITY THERAPY ROT15 435
減痙攣 SPASTICITY REDUCTION MOTION ROT16 436
其他經健保局核可者 OT OTHERS ROT17 437
SPLINT, LARGE S51-064 438
SPLINT, MED. S51-065 439
SPLINT, SMALL S51-066 440
OCCUPATIONAL THERAPY EVALUATION S51-077 441
OCCUPATIONAL THERAPY FOR HOME CARE S51-078 442
OCCUPATIONAL THERAPY,COMPLICATED 50 MINU S51-080 443
OCCUPATIONAL THERAPY,SIMPLE 30 MINUTS S51-081 445
OCCUPATIONAL THERAPY,MODERATE 30 MINUTS S51-082 446
OCCUPATIONAL THERAPY,MODERATE-COMPLICATED 30 MINU S51-083 447
RESTING SPLINT, SHORT LEG S51-084 448
RESTING SPLINT, LONG LEG S51-085 449
OCCUPATIONAL THERAPY,COMPLICATED 50 MINU XDAC980P 450
關閉(X)


建檔
帶入醫囑
物理(5) 職能(5) 語言(6) PAC物理 PAC職能 PAC語言
COMMUNICATION THERAPY,SIMPE 30 MINUTS S51-186 518
COMMUNICATION THERAPY,MODERATE 30-50 MIN S51-187 519
COMMUNICATION THERAPY,COMPLICATED 50 MIN S51-188 520
AUDITORY COMPREHENSION TRAINING RST1 521
VERBAL PRODUCTION RST2 522
AUGMENTATIVE COMMUNICATION SYSTEM RST3 523
READING TRAINING RST4 524
WRITING TRAINING RST5 525
VISUAL PERCEPTION RST6 526
HIGH LEVEL COGNITIVE FUNCTION TRAINING RST7 527
TACTILE STIMULATION RST8 528
ORAL TX. RST9 529
PHONETIC PLACEMENT RST10 530
AUDITORY DISCRIMINATION RST11 531
RHYTHM TRAINING RST12 532
AUDIOVISUAL FEEDBACK MONITORING RST13 533
ACOUSTIC ANALYSIS RST14 534
ST OTHERS RST15 535
SIMPLE SWALLOWING THERAPY S45-024-N 536
SWALLOWING EVALUATION (復健科) S48-151-N 537
SOUND RECORD TESTING (復健科) S48-107-N 538
COMMUNICATION THERAPY,SIMPE 30 MINUTS S51-103 539
COMMUNICATION THERAPY,MODERATE 30-50 MIN S51-104 540
SPEECH THERAPY EVALUATION S51-107 541
COMMUNICATION THERAPY,COMPLICATED,4 ITEMS MORE1URAN, 30 MIN MORE THAN 542
COMMUNICATION THERAPY,COMPLICATED 50 MINU XDAC108P 543
關閉(X)

(2) Onset超過一年:請開立「中度複雜」復健, PT / OT / ST:4 / 4 / 4 (3個用點的＋一個手動輸入S51-189(moderated-complicated))







2、 復健卡片：林口開卡用印的，桃分開卡用貼的

A. 林口：將診斷與Rehab Assessment直接印在卡片上。

(1) 每台電腦桌面上有「長庚復健卡工具」的資料夾

(2) 打開病患會診查詢到最後一次復健科的會診回覆頁面

(3) 按下enter，開始擷取

(4) 點選「復健卡」，修改成自己最新的診斷和評估

(5) 版面設定：字型：標楷體、字型樣式：標準、大小：11、版面設定：左邊界37mm，右邊界2mm、上邊界5mm、下邊界5mm

(6) 復健卡正面朝上放置，點選列印，卡片上請蓋上住院醫師章，並於卡片上按照開立項目「勾選治療項目」，再到復健櫃檯蓋上主治醫師章後，連同order單（需蓋章在上半部）一起交給櫃台姊姊。

B. 桃分：開完醫囑後order單會自動印出，請依照職類貼在對應的卡片上，每張卡片最上方需浮貼special procedure，以利病人身份辨識。

- 自費項目開立：**onset**大於一年的病人入住，大多已經跟主治醫師商討好要做什麼自費項目了。沒滿一年想要做也可以～目前常見有以下幾種

1、 IV laser：林口請跟主治醫師確認施打時間，桃分目前靖倫主任做至2026/07以前的所有人

★ 主任的病人會自己打，他會自己叫病人＋開order，其他人預計是自己打

2、 rTMS：林口目前是鍾維勵學長（星期二）、裴育晟醫師（星期三、四會由助理許筑亭協助安排，前一天告知她目前病房有在做的個案，她也會請R1初步篩選適合裴部做研究收案的個案）和黃書群醫師（星期五）（林口R1負責聯絡與統計時間），桃分3樓靖倫、裴，5樓翔寧、嘉玲、韶芝、建宏有在打，若病人主治醫師沒在打可以詢問主治要給誰打。

(1) 若病人有意願且主治醫師同意，要排EEG (awake)，備註寫for pre-rTMS evaluation，確認沒有腦部放電才能安排，有**seizure history**或是腦部有植入物的病人請與主治醫師確認過可以做。

(2) 目前裴育晟醫師和黃書群醫師的病人，如果沒有seizure history，不用等EEG有報告才安排，可同時安排EEG和直接安排rTMS

(3) 若腦部有開過刀靖倫主任習慣加排skull X ray，確認沒有金屬植入物

3、 自費機器人(分為上/下肢)：可以看orientation最後面

A. 上肢：治療同意書 + 自費切結書 + 張力評估書

B. 下肢：治療同意書 + 自費切結書

4、 體適能：填紅單，老病人直接拿給他們，新病人可以請人帶他們拿到B1體適能中心

5、 藝術 / 音樂 / 舞蹈治療：拿復健卡片，劃掉上面標題改成你要的，貼上special procedure即可（較少遇到，佩璇醫師team曾開立）

6、 肉毒：

A. Botox 醫藥囑開立：（有本科範本 - Botox injection）

★ 開立前請先詢問主治醫師想要以什麼方式打肉毒，方式有 anatomy guided / 電針 / echo guided / 電針＋echo guided，施打前請再三和主治醫師確認！

(1) 藥物開立：（可參考本科範本備註）

a. PRA051P (自費 / 健保)：BOTOX 100 IU 8000元/瓶

★ 病房「不用」領回藥物

★ 備註：「**病房請勿領回藥物** 請批庫台53900，注射_____ IU」，記得要以 IU 為開立單位

★ 若自費開立Botox，記得將藥囑單印出給書記批價。路徑：醫藥囑 - 列印 / 重印 - 選擇該筆醫囑時間 - 重整列印，蓋章後給書記

b. PRA054P (自費 / 健保)：Dysport 500 IU 9000元/瓶

★ 病房「要」領回藥物

★ 備註：只需註記「注射_____ IU」

★ Dysport 有自己的各部位施打劑量建議表，可參考以下資料

(2) 電針：84-034-041370 (自費 / 健保)：記得開order前要點選「材」再輸入，EMG Disposable Myoject Needle 0.41mm*37mm (肌肉注射用電針) 360元/支，備註「請批庫台53900」

(3) 注射費：S51-711 (自費 / 健保)：Anti-Spasticity Block 700元/條肌肉

(4) 超音波：（開立echo guide需打報告，若主治不打報告通常不charge這個order，如佩璇醫師會使用超音波，但通常不計價超音波）

- ✔ S51-338 (自費)：Nerve Block Injection With Ultrasound Guidance (超音波引導神經阻斷術) 800元/次
- ✔ M23-041-N (自費 / 健保)：Echo Guided Needle Aspiration (超音波導引下抽吸術) 1500元/次

B. 以上注射費、電針、超音波根據施打的肉毒是自費還是健保決定要不要自費(ie, 若健保申請則全部都健保)。

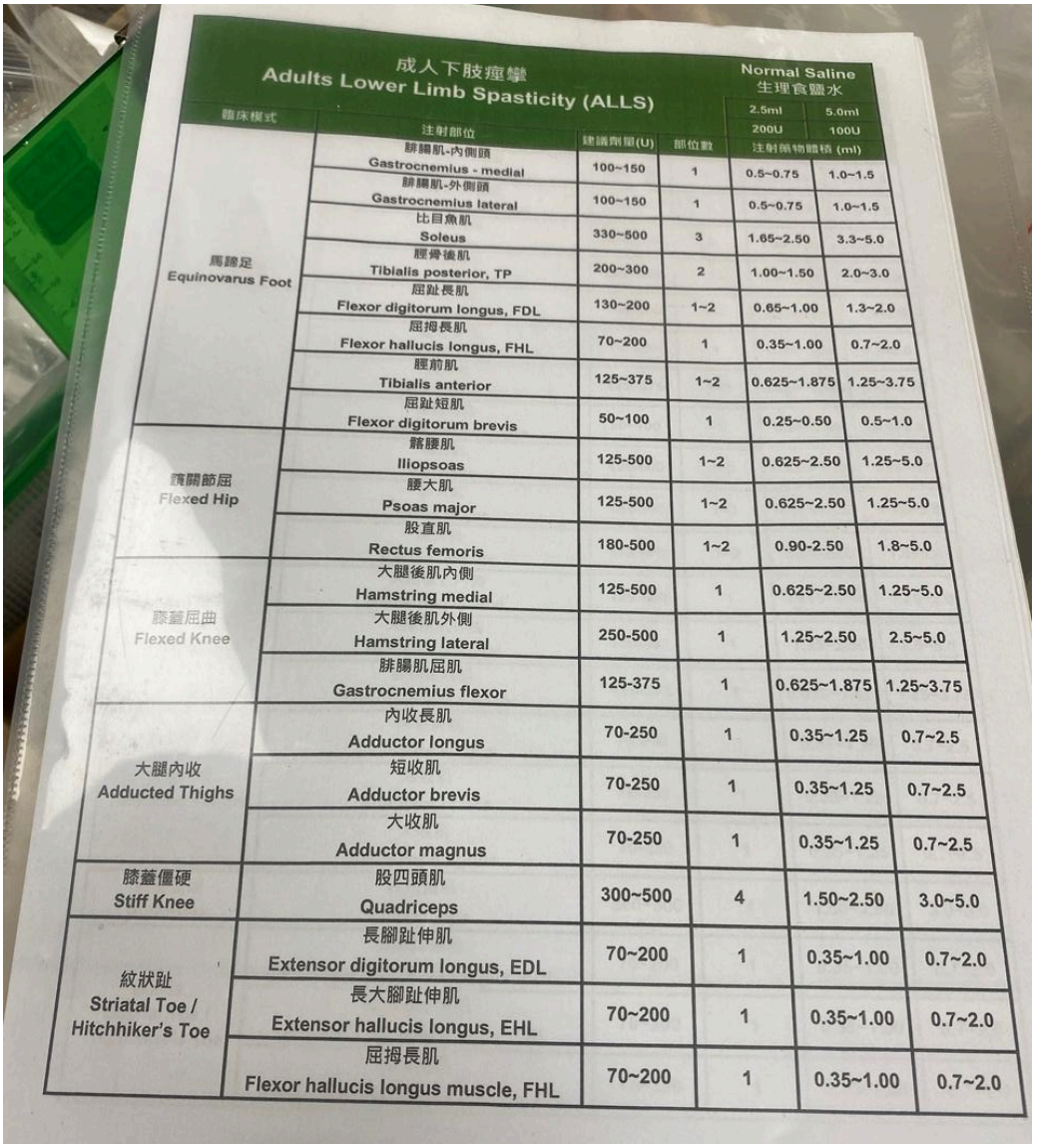
C. Botox 同意書開立：通常開完醫囑會自動帶出同意書，若無則依以下方式開立：

住院：功能選單 - 病歷記載 - 同意書 - 同意書開立 - 治療同意書 (MR20-C)

D. 打完肉毒記得完成special procedure note, 桌面有範本*****

E. Botox和Dysport都有各自的廠商，通常要施打時要跟廠商約時間。中風後超過三個月可以申請健保肉毒，若需要主治醫師會自行跟廠商聯繫。(佩璇醫師只打自費)

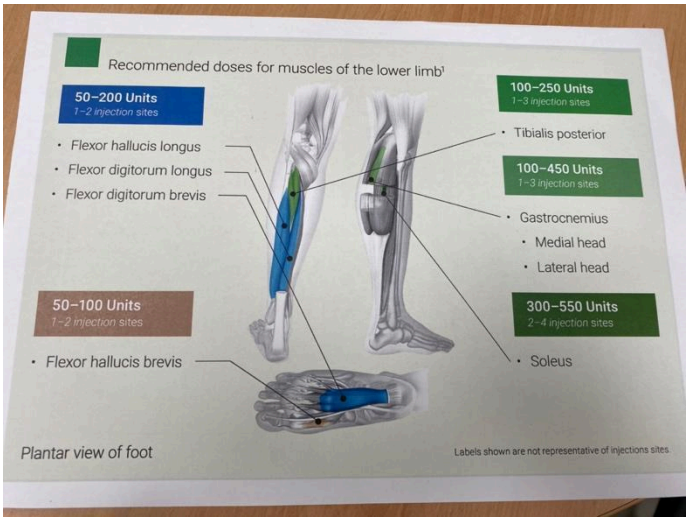
以下附上dysport參考資料，Botox可以參考另一份檔案：

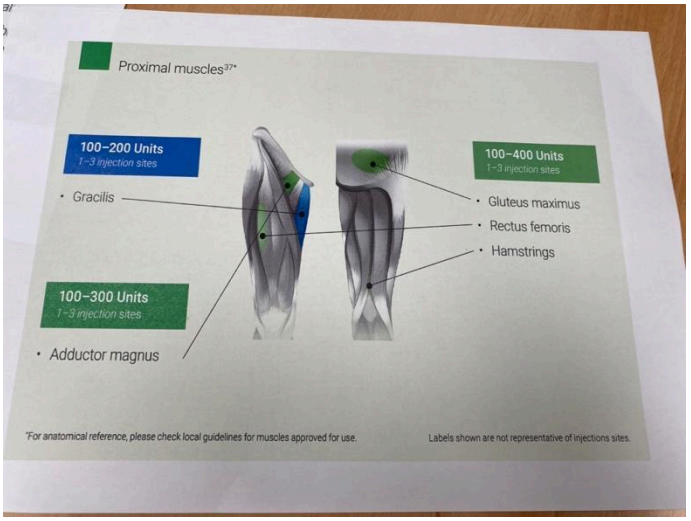


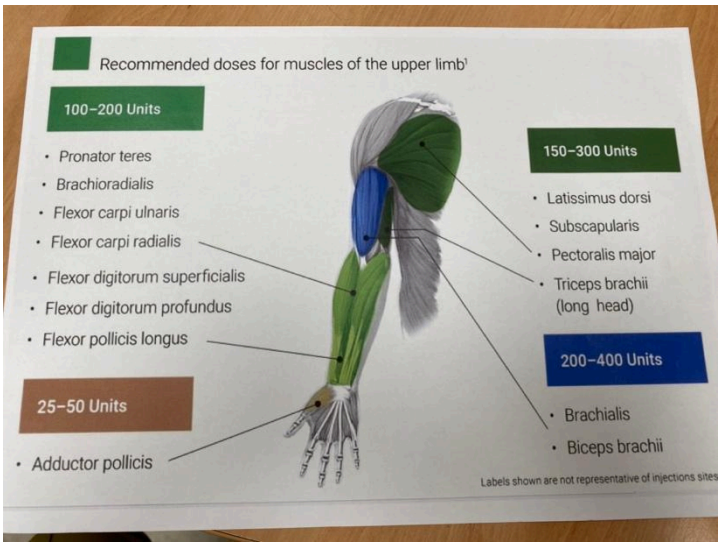
成人下肢痙攣
Adults Lower Limb Spasticity (ALLS)

Normal Saline 生理食鹽水

臨床模式	注射部位	建議劑量(U)	部位數	2.5ml 200U 注射藥物體積 (ml)	5.0ml 100U 注射藥物體積 (ml)
馬蹄足 Equinovarus Foot	腓腸肌-內側頭 Gastrocnemius - medial	100~150	1	0.5~0.75	1.0~1.5
	腓腸肌-外側頭 Gastrocnemius lateral	100~150	1	0.5~0.75	1.0~1.5
	比目魚肌 Soleus	330~500	3	1.65~2.50	3.3~5.0
	腰骨後肌 Tibialis posterior, TP	200~300	2	1.00~1.50	2.0~3.0
	屈趾長肌 Flexor digitorum longus, FDL	130~200	1~2	0.65~1.00	1.3~2.0
	屈拇長肌 Flexor hallucis longus, FHL	70~200	1	0.35~1.00	0.7~2.0
	腰前肌 Tibialis anterior	125~375	1~2	0.625~1.875	1.25~3.75
	屈趾短肌 Flexor digitorum brevis	50~100	1	0.25~0.50	0.5~1.0
髖關節屈 Flexed Hip	髂腰肌 Iliopsoas	125-500	1~2	0.625~2.50	1.25~5.0
	腰大肌 Psoas major	125-500	1~2	0.625~2.50	1.25~5.0
	股直肌 Rectus femoris	180-500	1~2	0.90-2.50	1.8~5.0
膝蓋屈曲 Flexed Knee	大腿後肌內側 Hamstring medial	125-500	1	0.625~2.50	1.25~5.0
	大腿後肌外側 Hamstring lateral	250-500	1	1.25~2.50	2.5~5.0
	腓腸肌屈肌 Gastrocnemius flexor	125-375	1	0.625~1.875	1.25~3.75
大腿內收 Adducted Thighs	內收長肌 Adductor longus	70-250	1	0.35~1.25	0.7~2.5
	短收肌 Adductor brevis	70-250	1	0.35~1.25	0.7~2.5
	大收肌 Adductor magnus	70-250	1	0.35~1.25	0.7~2.5
膝蓋僵硬 Stiff Knee	股四頭肌 Quadriceps	300~500	4	1.50~2.50	3.0~5.0
紋狀趾 Striatal Toe / Hitchhiker's Toe	長腳趾伸肌 Extensor digitorum longus, EDL	70~200	1	0.35~1.00	0.7~2.0
	長大腳趾伸肌 Extensor hallucis longus, EHL	70~200	1	0.35~1.00	0.7~2.0
	屈拇長肌 Flexor hallucis longus muscle, FHL	70~200	1	0.35~1.00	0.7~2.0







- 其他處置:
  1、 TENDON INJECTION (復健科) N46-011-N
  2、 乾針:MYOFASCIAL TRIGGER POINT DRY NEEDLING S51-122
  3、 Trigger point injection S51-335, 請和主治確認後額外開立欲注射的藥物

  註:要記得開, 並註記施打什麼藥物在哪個部位, 技術費是唯一主治醫師會有拿到錢的項目。不管健保或自費開的藥物, 主治醫師都不會分到錢~

- 中醫針灸、服用中藥：

  針灸：

  3樓與5樓政策不同，3A基本上所有主治醫師都會同意，所以病人想做可以直接會診。5A基本上要先問過主治醫師（尤其是佩璇醫師），主治醫師同意後請護理師或助理員幫忙登記，評估前一天下午會再請你開會診單(一個禮拜三天)。

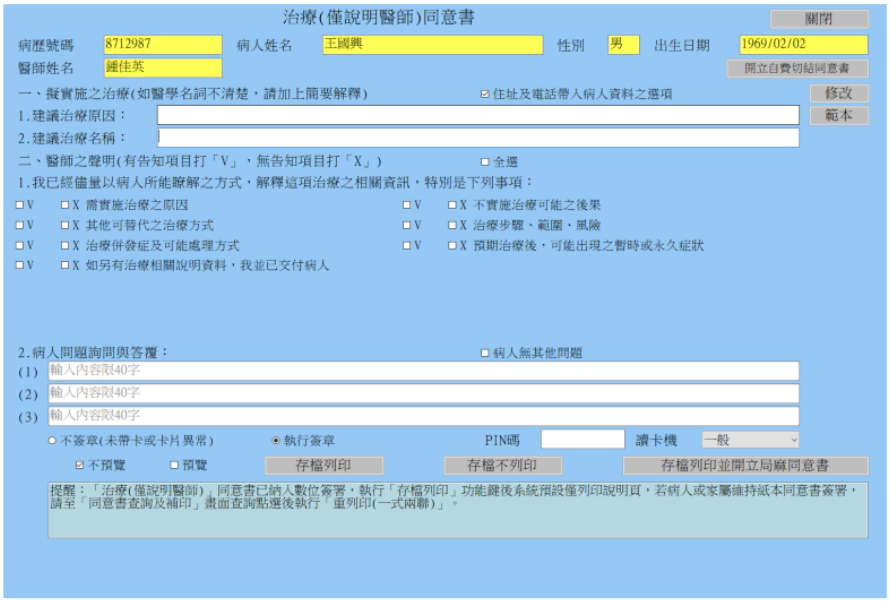
  中藥：

  不論是自備中藥還是本院中醫開的中藥，皆需詢問主治醫師(尤其ischemic stroke服用抗血小板or抗凝血劑)。主治醫師同意後即可會診中醫內兒科（自備中藥就不用）。之前曾經討論過要開立同意書，但實務上都沒再開了，如果主治醫師要求要有同意書的話，以下開立方法供參考。

  選取「治療同意書」



  建議治療原因：填寫該病人主診斷
  建議治療名稱：填寫「中藥治療」
  病人問題詢問與答覆：填寫「醫師已明確告知中西藥共同服用所造成交互作用迄今未明,病人對服用中藥可能造成的不良作用願負責任」
  簽章後護理端可請病人/家屬簽署



PAC復健單及復健卡片

大多病患來源會是林口，少數是外院轉入。差別在於林口來的病人會有我們神內醫師的神內訪視，但外院病人全都沒有！！！若病人有藥物或是臨床問題，可與神內醫師討論！

- 中風PAC:（最長可住到12週，個管師會聯繫請我們開展延，原則上病人隨時可以出院，但要告知病人需提早說，並聯絡**PAC**個管師汪雨璇）

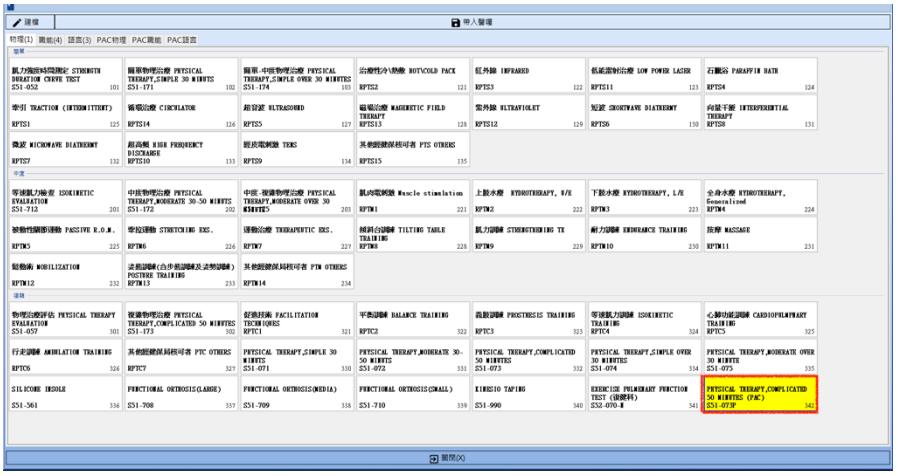
1、 Admission order及note同一般病人，但輸入Special procedure note請於診斷最上面加註「***PAC program***」

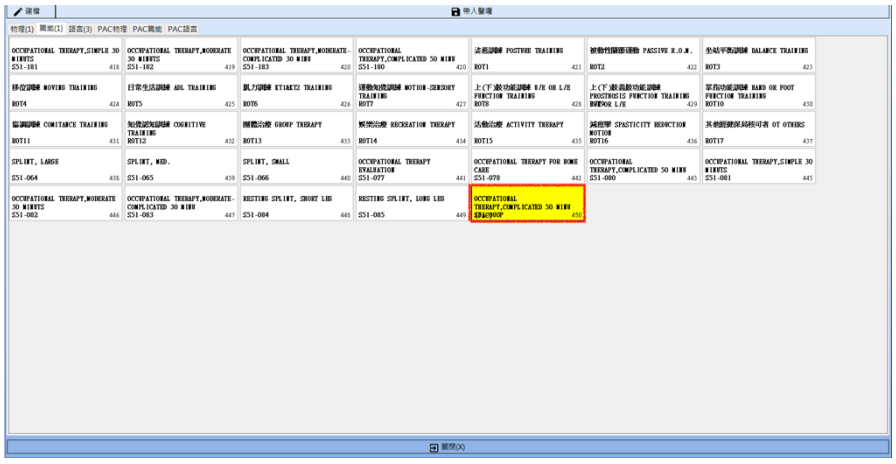
2、 DAPT停用時間確認。雖然PAC每週也會有神內醫師自己看自己打VS note，但一定要記得從林口會診單or林口神內病歷or林口神內醫囑備註確認DAPT到期日，吃超過就尬了。不過這個也可以上班時段team+問**PAC**個管師汪雨璇**(超罩)**。

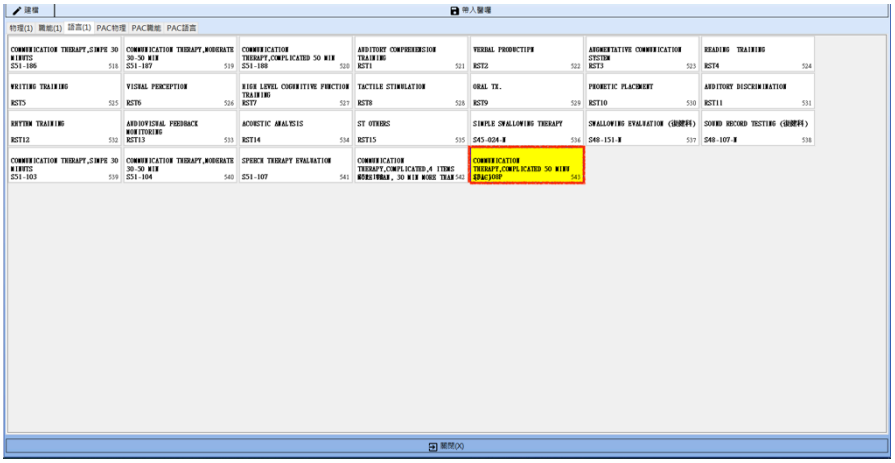
3、 復健Order及卡片開立:

1. 依樣畫葫蘆，點進復健治療內，分成兩個部分:

(1) PAC物理/職能/語言專用項目:***請單獨存取這筆order***



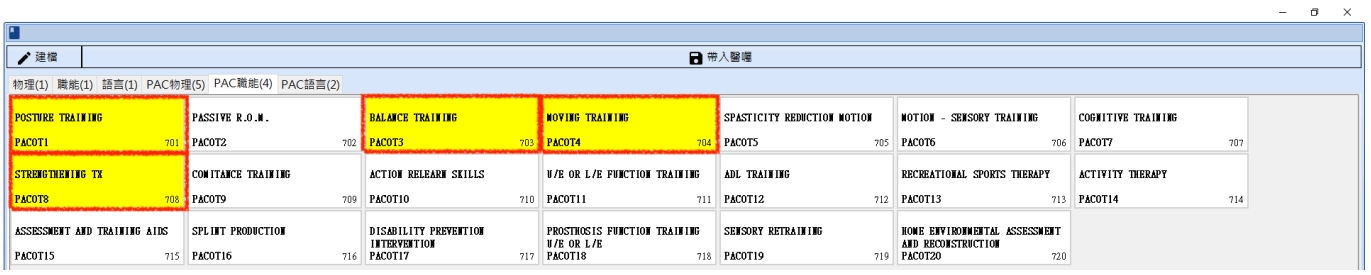




(2) 復健細項開立:

✔ 有ST需求:PT 5 / OT 4 / ST 4

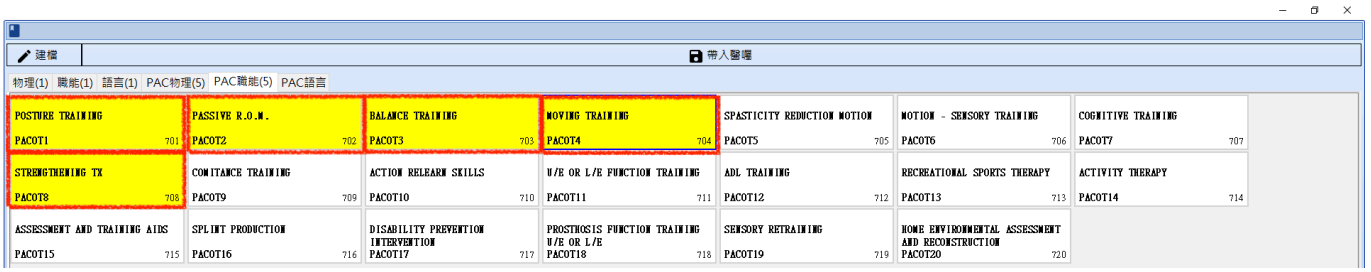


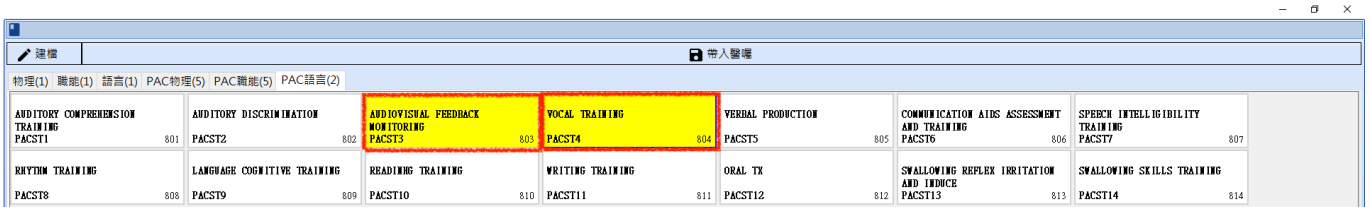




✔ 無ST需求，仍會請老師做一次評估確認需要與否，所以也會點選ST，只是項目較少：PT 5 / OT 5 / ST 2



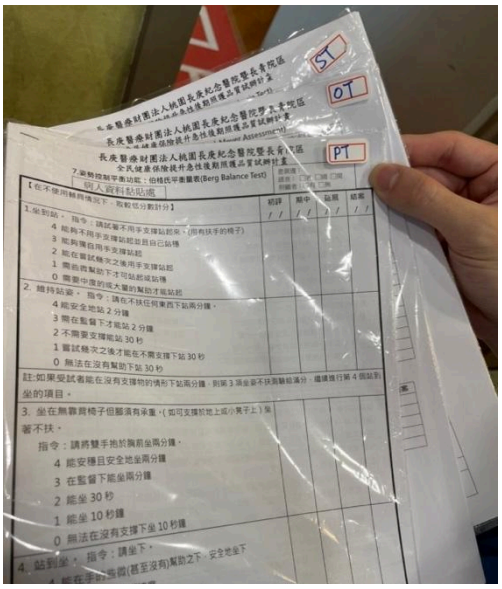




(3) 請將(1)、(2)印出的order單連同special procedure一同貼在復健卡片上。

(4) 從5A資料夾中拿出PAC專用的PT / OT / ST的評估單釘在相應職類卡片上。

(5) 最後在卡片最上方加蓋「PAC個案快速通關」的印章





2. PAC計價order：請在個管師告知的評估日期送出order及完成評估，否則會影響健保點數，你會被老闆殺死。若真的忘記過幾天要補，請在備註欄註記本來應該評估的時間。

   (1) 入院當天初評：P5114B 承作醫院評估費(初次)

   (2) 期中、展延評估(個管師會提醒你)：P5115B承作醫院評估費(複評)

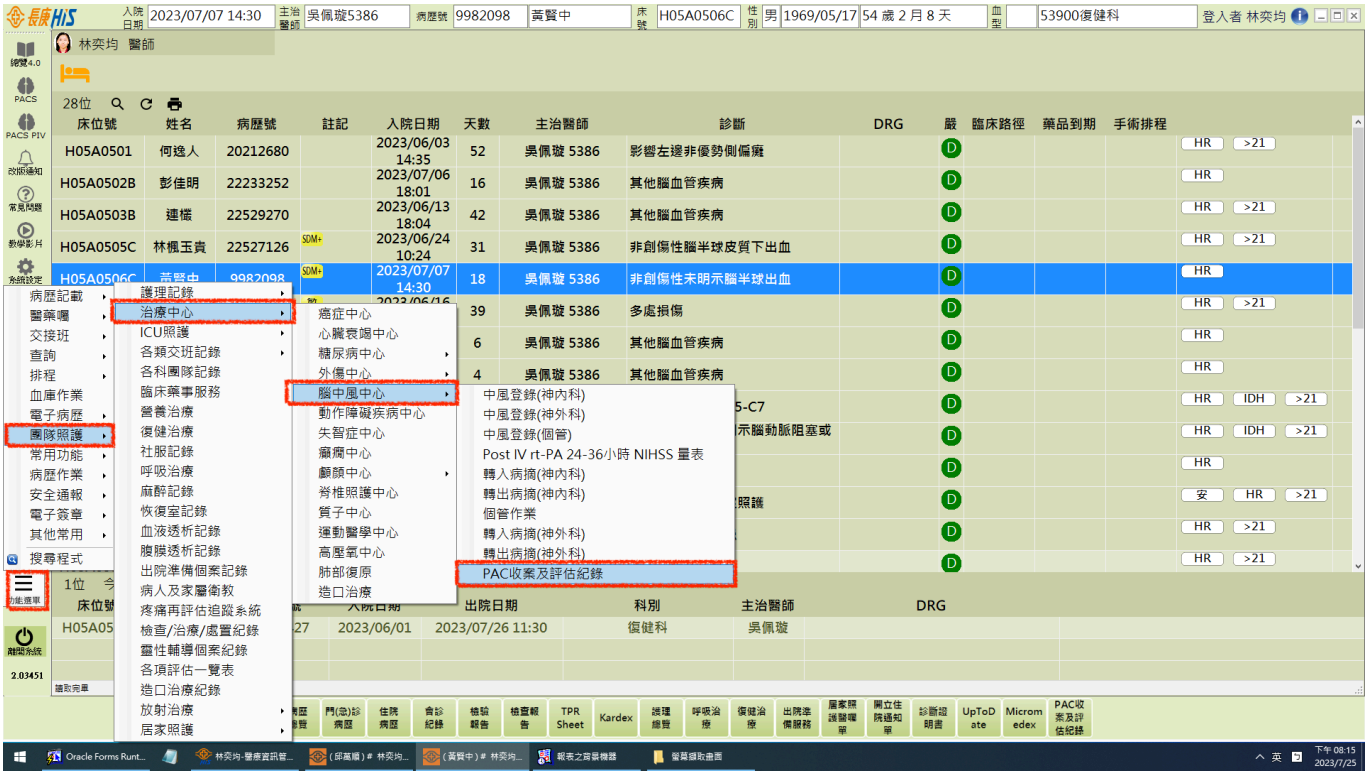
   (3) 結案評估：P5117B 承作醫院出院準備及結案評估費





4、 PAC病人評估及系統輸入：(開評估單同時完成)

1. 步驟：功能選單 - 團隊照護 - 治療中心 - 腦中風中心 - PAC收案及評估紀錄



2. 點選對應病人



*MNA評上半部即可

5、 出院病歷：診斷最上方需註記：Complete PAC/ terminate PAC

6、 出院回診：掛神經科門診、是否需要復健科門診跟主治醫師確認（看病人後續想去哪裡做復健）。

- 骨折PAC：（請直接跟病人說最多住2週出院，也就是13天後就出院回家，因為桃分等PT OT要等一周，住院目的是學習輔具使用、銜接醫院與居家生活準備，避免對復健有太高期待）（有需要可再展延1週，但先不提）

1、 Admission order及note同一般病人，Special procedure note需要三個子項目：

(1) 診斷，請加註「***PAC program***」

(2) 復健評估

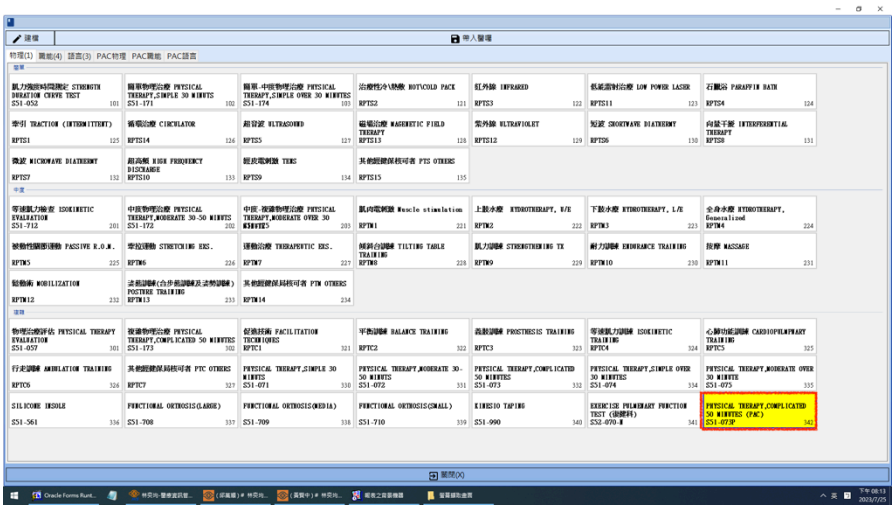
(3) 評估後寫上巴氏量表、疼痛指數、Harris hip score（適用於髖關節置換術後）

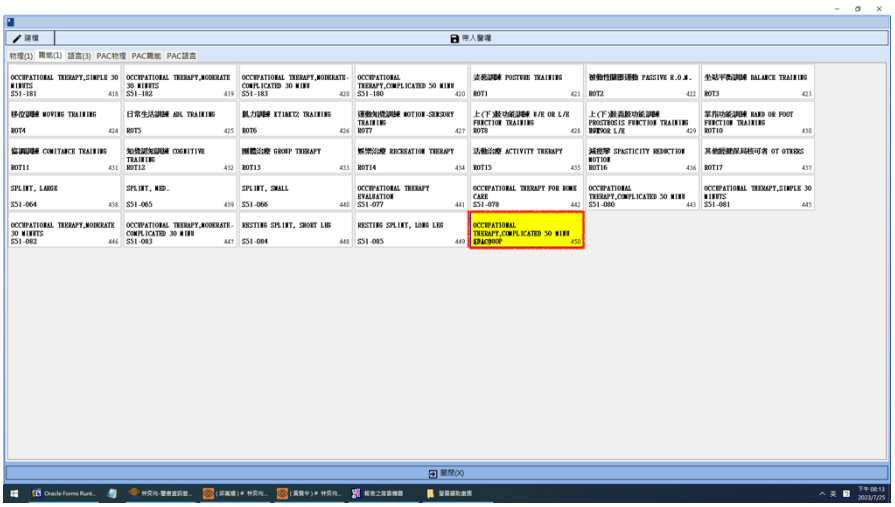
2、 復健Order及卡片開立：

1. 依樣畫葫蘆，點進復健治療內，分成兩個部分：

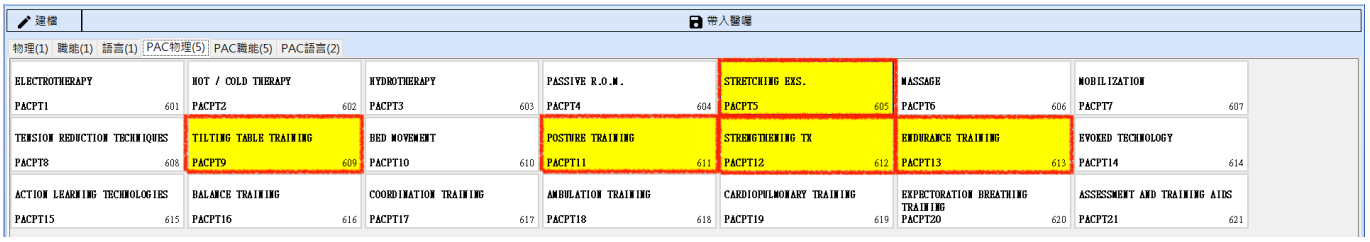
(1) PAC物理/職能專用項目：***請單獨存取這筆order***（PT/OT即可）

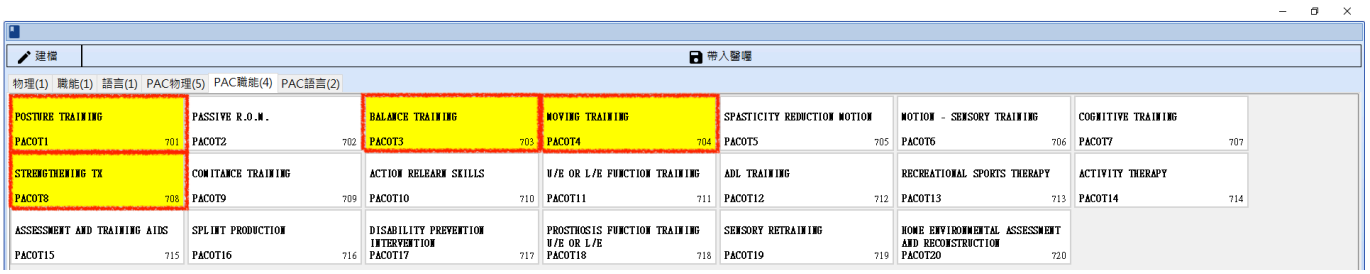
尸 业





(2) 復健細項開立:





(3) 請將(1)、(2)印出的order單連同special procedure一同貼在復健卡片上。

(4) 沒有PT / OT / ST的評估單。

(5) 最後在卡片最上方加蓋「PAC個案快速通關」的印章。

2. PAC計價order：請在個管師告知的評估日期送出order及完成評估，<u>不用進PAC系統評估</u>

   (1) 入院當天初評：P5114B 承作醫院評估費(初次)

   (2) 展延評估(個管師會提醒你)：P5115B承作醫院評估費(複評)

   (3) 結案評估：P5117B 承作醫院出院準備及結案評估費





3、 PAC病人評估：入院當天special procedure note上的巴氏量表、pain score、(Harris hip score)即可當作評估，後續評估個管師會處理。

4、 出院病歷：診斷最上方需註記：Complete PAC/ terminate PAC

5、 出院回診：約骨科醫師門診即可(有時骨科醫師會先幫病人約好門診，請再確認)，不需約復健科醫師門診。

- 衰弱PAC:(至少住2週，3週需出院，需要可展延1週)(2-4週)

1、 Admission order及note同一般病人，Special procedure note需要兩個子項目:

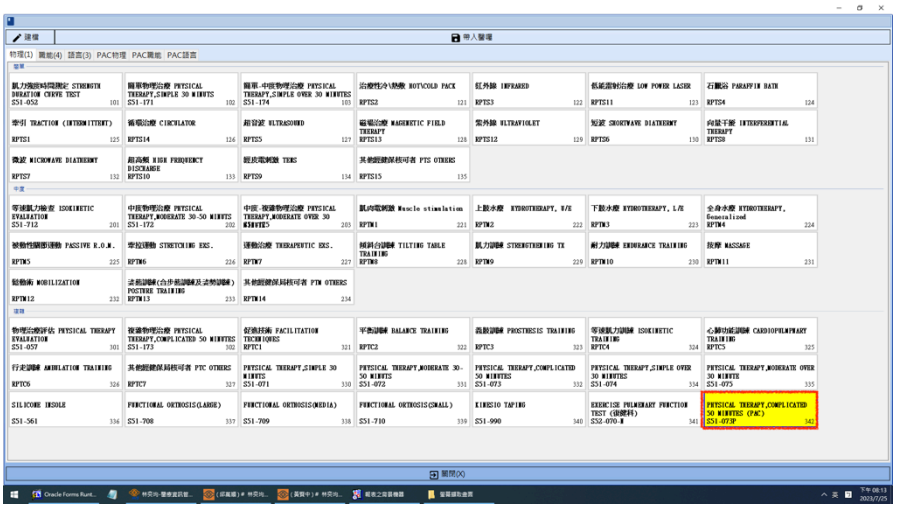
(1) 診斷，請加註「***PAC program***」

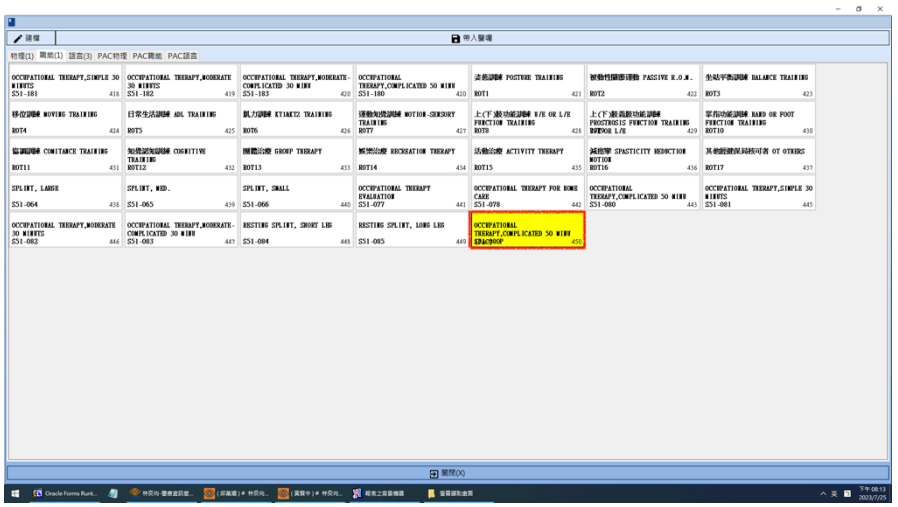
(2) 復健評估

2、 復健Order及卡片開立:

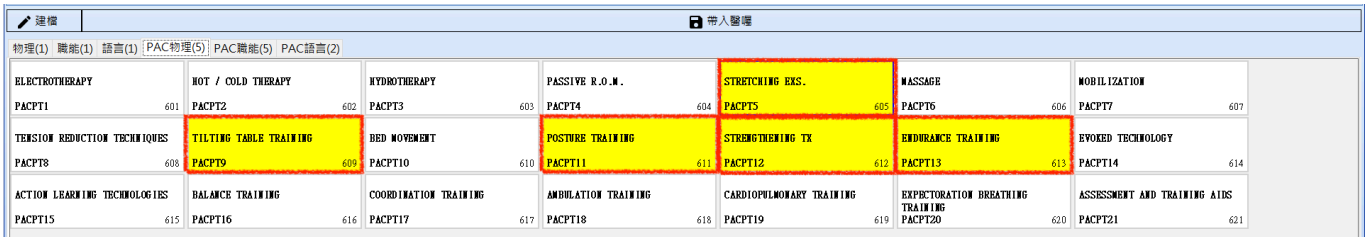
1. 依樣畫葫蘆，點進復健治療內，分成兩個部分:

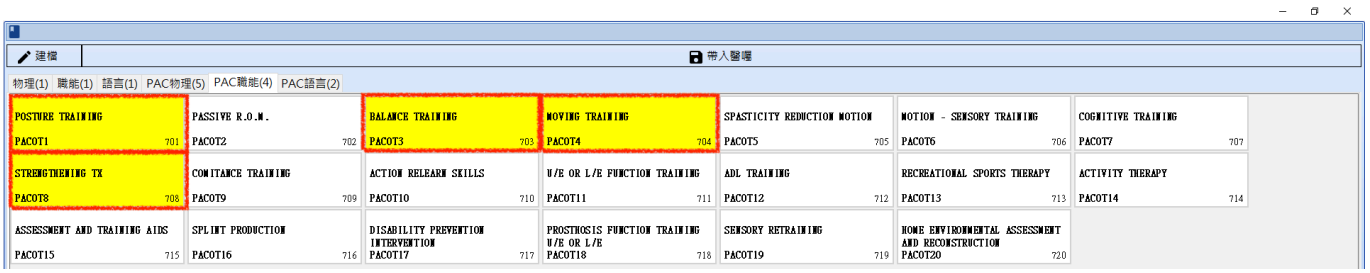
(1) PAC物理/職能專用項目:***請單獨存取這筆order***(PT/OT即可)





(2) 復健細項開立:





(3) 請將(1)、(2)印出的order單連同special procedure一同貼在復健卡片上。

(4) 沒有PT / OT / ST的評估單。

(5) 最後在卡片最上方加蓋「PAC個案快速通關」的印章。

2. PAC計價order：請在個管師告知的評估日期送出order及完成評估，<u>不用進PAC系統評估</u>

(4) 入院當天初評：P5114B 承作醫院評估費(初次)

(5) 展延評估(個管師會提醒你)：P5115B承作醫院評估費(複評)

(6) 結案評估：P5117B 承作醫院出院準備及結案評估費





3、 PAC病人評估：略，個管師處理。

4、 出院病歷：診斷最上方需註記：Complete PAC/ terminate PAC

5、 出院回診：向主治醫師確認是否約回診

PAC 開單注意事項 2026/7/22

●**入院當天**初評 order 開→P5114B 承作醫院評估費(初次) ●期中、延展評估 order 開→P5115B 承作醫院評估費(複評) ●結案評估 order 開→P5117B 結案評估費 **複評、展延可於”設定日前後 3 天”開單+評估，如果漏開請在備註註記(on 日期) **結評可以計價在出院日或出院前一日，故如果要 W7 出院，可以 W5 開出院 order 先辦，但是結評 P5117B 請務必註記”on W6 日期”。
復健項目開立： ◎主項：工具箱>復健治療>物理治療/職能治療/語言治療的”最後一項”(...PAC) ◎細項：只能在 PAC 物理/PAC 職能/PAC 語言裡選擇(勿選一般復健項目，如果套組裡沒有就不可以做!!)
[脆弱骨折].住院時間：至少住 1 周，2 週需出院，需要再展延一週 **[衰弱高齡]**住院時間：至少住 2 周，3 週需出院，需要再展延一週 **[腦中風]至少住 3 周**，住院 6 週為主，有需延展的病患，於第 5 週複評&個管師會協助資料送健保局審查，健保局決定延長時間，最多再延長 1-6 週不等。 **提早出院只要 VS 同意就可以(**治療師**來不及結評也沒關係，但**醫師**一定要評估分數)，但是不可以延後日期出院(一天都不行)**
[腦中風醫囑] ****無論有無上 ST，PT*5 項**(其中一項開 Facilitation or Balance or Ambulation) OT*5 項 1.有 ST：ST 項目***4** 2.無 ST：ST***2**(for 評估) **[衰弱、骨折醫囑]** PT*3 (其中一項要 Facilitation or Balance or Ambulation) OT*3 [其他補充] •病人開副木：PACOT→ st. splint production 加註名項目； •電療：PACPT1→Electrotherapy 註名項目

補充：(1)PAC 病人可隨時退出計畫 (2)有急性問題出院回林口， PAC 中斷，不用結評
(3)再次中風，符合 PAC 收案條件，可再重新收入院，PAC 住院時間重新計算

[腦中風評估] HIS 住院醫囑→團隊照護→治療中心→腦中風中心→PAC 收案及評估記錄→點選病人→進入評估→復健科→MRS~IADL(MNA 評上半部即可)。

[骨折評估] **不用進 PAC 系統評分**

請於 Admission note 或 progess note 註記 1.ADL 分數(推薦使用本科範本帶入巴氏量表)
2.疼痛 NRS 分數 3.如果開刀髖關節需評 harris hip score(病房有放護貝版)

[衰弱高齡評估] **不用進 PAC 系統評分**
要評的項目非常多，請直接使用”紙本評估”(沿用上游醫院，或是從本子拿)。

[開卡]

1.3T 治療卡須黏貼：病歷、治療單(主項+細項)、****務必蓋 PAC 章****((才會加快排課+排兩堂課))
2.**腦中風**需要在治療卡後”**釘**”評估表

出院病摘需帶入出院照護計畫書內容、出院帶藥、約診神內/骨科/老醫
[無特殊需求，不約回復健科門診](如果要排長庚門診復健，請約該院區門診，會診開單開卡)
桃分沒有人力做門診 OT 和門診 ST

林口Survival Guide

- 病人來源

1、 門診:admission order / note 、on duty note(困難插管評估)、病人自備藥物 、復健order、復健卡片

2、 他科轉入:order renew (類似於admission order，見本科範本)、on duty note(困難插管評估)、acceptance note (如果是外科轉入的，大多history為條列式…請統整為整篇文章式，再加上復健評估)、病人自備藥物 、復健order

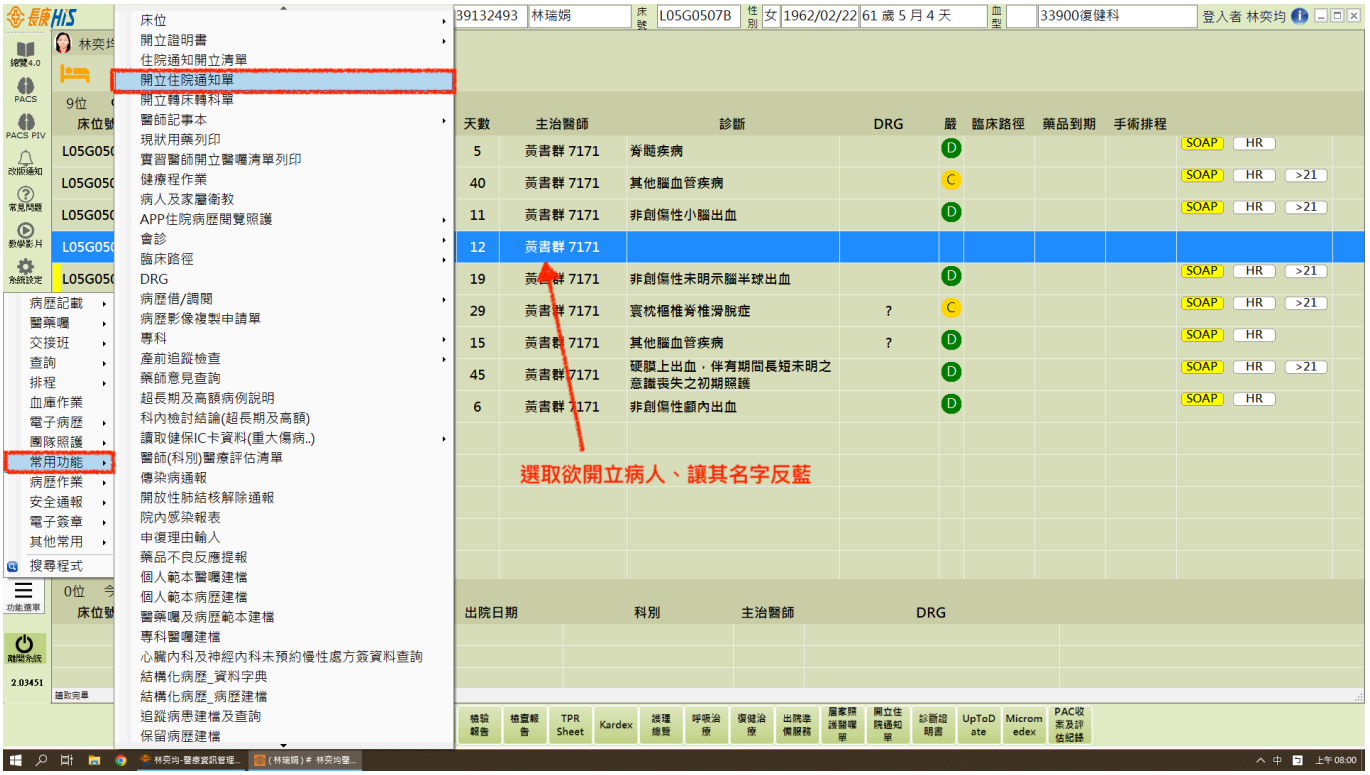
★ 他科轉入的病人大多已會診過復健科開立過卡片，如果評估後需要做的復健卡，過去的會診單沒開到，請跟林口CR或是復健櫃檯的千雁姐確認，再重新開卡

3、 動向:林口病人動向後續可有以下幾種:回家、桃分、基隆土城(較少，告知總醫師床號、病歷號，若同意則進一步開立住院單)、養護機構、其他醫院 (樂生、署桃、新屋、桃榮、輔大…)

1. 如果病人要回家，不再住院，有長照需求者，請在至少三天前會診轉介;管路帶回家者，可順便詢問是否符合居家換管

2. 住院單開立:(以桃分為例)

(1) 點選病人 - 功能選單 - 常用功能 - 開立住院通知單



(2) 進入開立住院單的頁面，會跳出病人住院中，是否重複開立，請按「是」

(3) 以下有幾個欄位需要做填寫:

✔ 簽住院區:5. 桃園長庚

✔ 特殊床位:H. 慢性床

✔ 醫師代號:請簽 8941 (會自動跳出吳致寬醫師的名字)

✔ 主診斷：單擊patient list的DRG欄位，複製貼上最下面的主診斷，常用代號：I6789其他腦血管疾病(最常用，ICH, ischemic stroke都可以)/ I619自發性腦出血/**T07(多處損傷，TBI SCI都可以用)

✔ 預定住院日期：輸入住院第一順位、第二順位會自動加一天

✔ 其他說明：住院單壓到期日(約四週)，範例：此住院通知單有效至2023/09/05

✔ 是否為復健：Y.是

✔ 功能障礙：C42. 重癱 (無論如何請務必點選重癱)

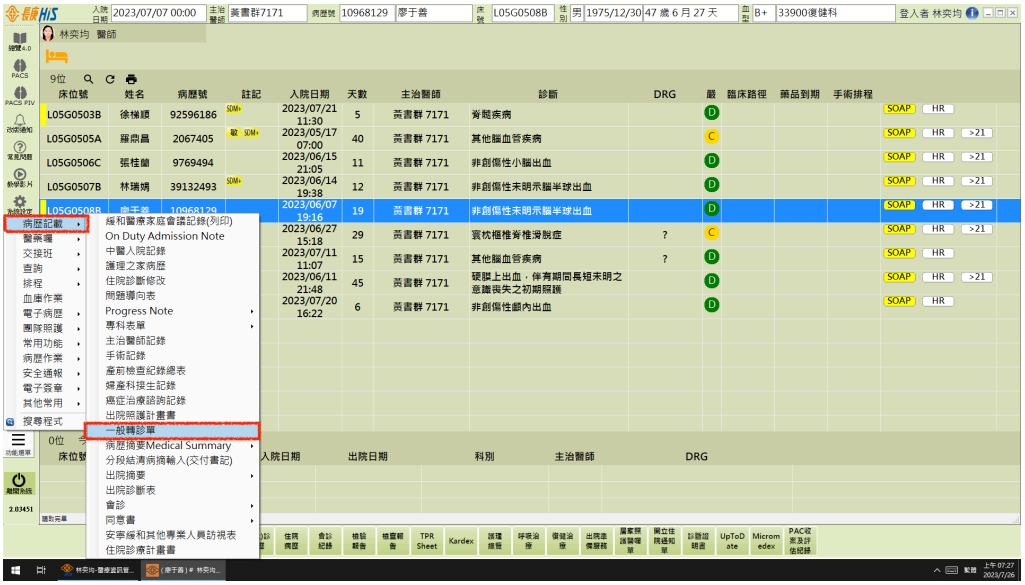


(4) 住院通知單印出後，呈現如下：請在主要負責醫師8941吳致寬後面加上(3A)，以及下面加寫8047 陳建宏(5A)，最後蓋上自己的章，旁邊寫「代」，開完後請交給護理師他們會完成後續流程，但請記得開order，開立「住院通知單」，備註寫「桃分復健科since OO/OO~」

(5) 如果有指定要轉給桃分的某位主治醫師，則在「醫師代號」中填該醫師的碼

3. 轉診單：林口轉至桃分需要另外開立轉診單

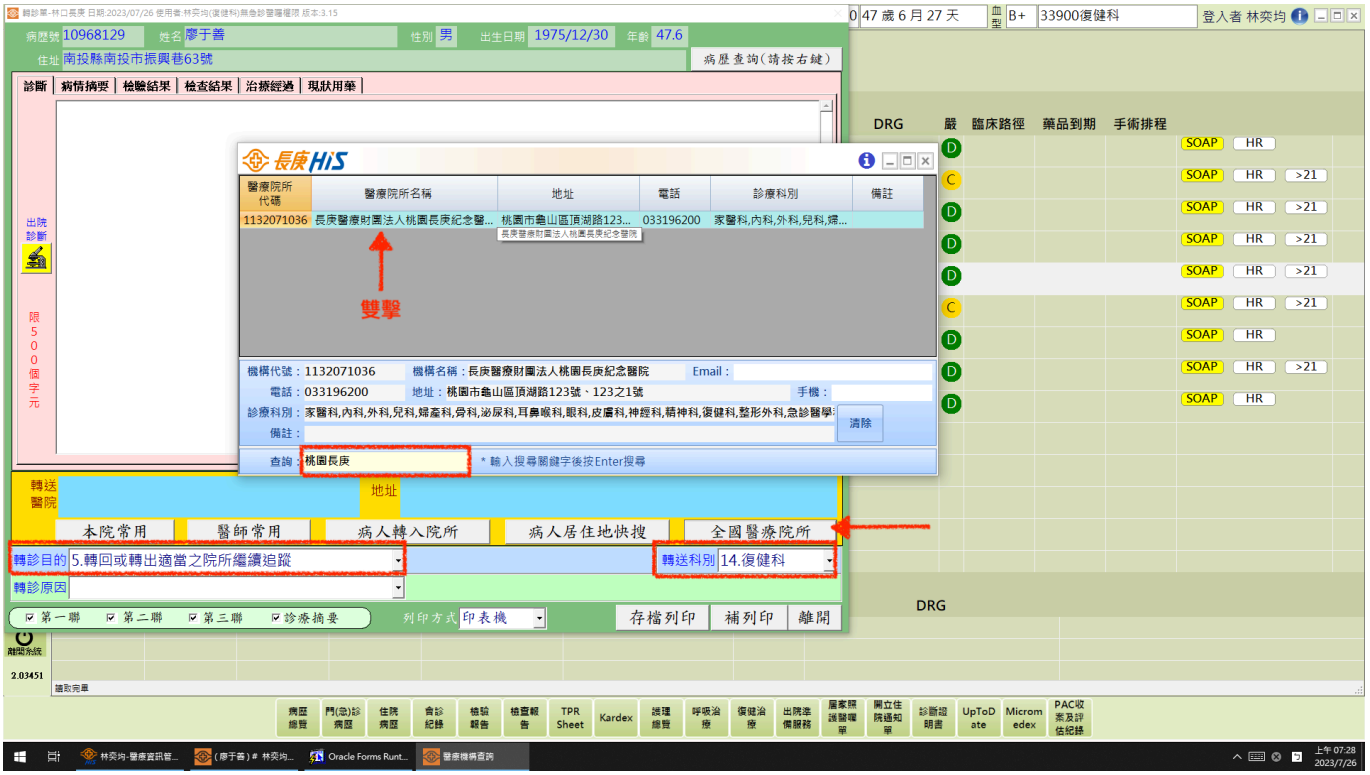
(1) 點選病人 - 功能選單 - 一般轉診單



(2) 進入轉診單頁面 - 點選全國醫療院所 - 在查詢處輸入:桃園長庚 - 上方跳出桃分選項後「雙擊」他就會自動帶入 - 帶入後轉診目的請選擇「5. 轉回或轉出適當之院所繼續追蹤」、轉送科別請選擇「14. 復健科」

(3) 診斷就寫最重要的診斷即可，其他各欄位請填寫as discharge summary

(4) 如果跳出緊急救護單，一定要按取消！！



桃分Survival Guide

- 在病房遇到狀況時的處置方法:

1、 桃分編制:除了復健科外，還有5G的內科好朋友(胸腔科、腎臟科、腫瘤科)、5F外科 (骨科、整外)、7樓精神科、8樓中醫自費病房

1. 當有需要急救的狀況時，會廣播全院999，雖然999有劃分地區，但桃分科別偏少，人員配置也不是太充足，復健科又是整個桃分人數最多的科別，請所有人在桃分聽到999時立即前往支援幫忙。
2. 若病人有會診其他專科的需求，桃分大部分科別是請當天有門診的醫師看會診，因此有些科別不是每天都能會(e.g., 感染科，但可以先會再說，沒診會打電話跟你說），桃分無急會診，急事請直接打電話或送林口。
3. 桃分有洗腎室，所以可收洗腎病人，但不接受緊急洗腎
4. 桃分雖設有急診，但只有一位主治醫師及兩位護理師，住院病人狀況不穩定只能去林口長庚急診(不要給病人桃分急診的選項，被問就直接說沒辦法，若病人要入院時vital sign不合入住規定，如有必要也請病人去"林口急診"就診)，另外當天值班人員需要支援跟車桃分轉送林口急診的病人(會接到急診的電話，就要下去急診準備跟車)

   註:住院病患出事，桃分急診救不了你，但桃分急診有需要跟車的病患，當天值班不管在忙什麼，都一定要去跟車。

5. 檢驗 & 檢查

   (1) 檢驗室與X-ray是跟著門診時間走，夜診結束後就沒有了

   ★ 開立常規(白話:沒有很急)的X-ray之前請和護理師確認一下還可不可以照，不然就明天再來了

   ★星期六日下午會有一個時段可做X光。(請跟護理師確認時間)

   (2) 夜間檢體 ~~(晚上10點後)要坐交通車或救護車去林口，待林口檢驗室做，等待時間較長~~ 可喜可賀，2026/06開始，24小時都能抽血看報告了~

   (3) 夜間檢查或假日有特殊需求時，例如病人跌倒要急做brain CT (只能non-contrast)，可以call林口的值班放射師來桃分 (GSM:63099)，如果沒通可call羅組長 (GSM:62827)，如果急需文字報告可試著打去X光科催

6. 護病比:1 : 35-50。慢性病房護病比非常高，所以有急性問題時，整個醫療團隊執行較慢，且規定不能輸血...，也不能做pre-OP
7. 問題處置:需要靠各位的臨床判斷，評估是否為「桃分內科」可處理，如果不行需進一步轉至林口急診

   (1) 欲轉桃分內科(僅平日白天):依照病人狀況 (胸腔問題、腰子問題等)可發給對應科別takeover的會診，感染科目前沒有收住院醫師，可打去病房問問看。原則上只有胸內跟腎內會take over ~

   (2) 內科是「幫忙」我們，切記勿讓對方有不舒服的感受，禮貌的詢問，以免影響日後對方收我們病人的意願

8. 送林口急診

(1) 需先確認,「非桃分內科」所能處理的。

(2) 評估需要後送至林口急診時需要有以下步驟:

✔ 先致電家屬做病情解釋, 及說明目前病況所需需要送至林口急診做進一步處置 (要記得這是一種告知, 而非取得同意, 因為我們慢性病房無法做積極處置, ex 放CVC、輸血 ！)

✔ 接著致電林口急診內科進行交班, GSM: 68945 or 403-2143#362, 需要告知是什麼病人及送急診原因

✔ 完成口頭交班後, 請護理師跟林口急診訂床並打電話叫救護車, 救護車又分普通車跟急車, 急車會在15分鐘內到達、普通車一小時內, 且依照病人狀況決定是否需要跟車, 若有需要, 請護理師要叫「來回車」, 不然你去了後會被丟在林口回不來, 那就慢慢等接駁車回來吧…

★ 何時要跟車:vital signs unstable、預期會有變化

★ 若要跟車, 請打給二線說要去跟車, 請他們cover, 也要告訴護理站若有急事請摳二線

★ 若有轉病人, 請記得「傳簡訊」告知主治醫師, 隔天也要口頭交班

✔ 完成上述作業後, 就剩下一些紙本作業了:轉診單、出院病摘、鎖床單、住院通知單、不需帶出院帶藥, 最後再開Discharge order(很重要！！)

★ 沒有鎖床單跟住院單的話, 病患如果被急診確認不用住院要丟回桃分, 就會回不來, 變成人球。鎖床單就是開轉床單, 只是註記「保留床位至202X/XX/XX(隔天)08:00AM」, 住院單則是開一樣的日期, 但不要寫截止時間, 因為書記都是早上8點才上班。

★ 若隔天確定不需保留床位, 請跟病房書記告知, 取消住院通知單

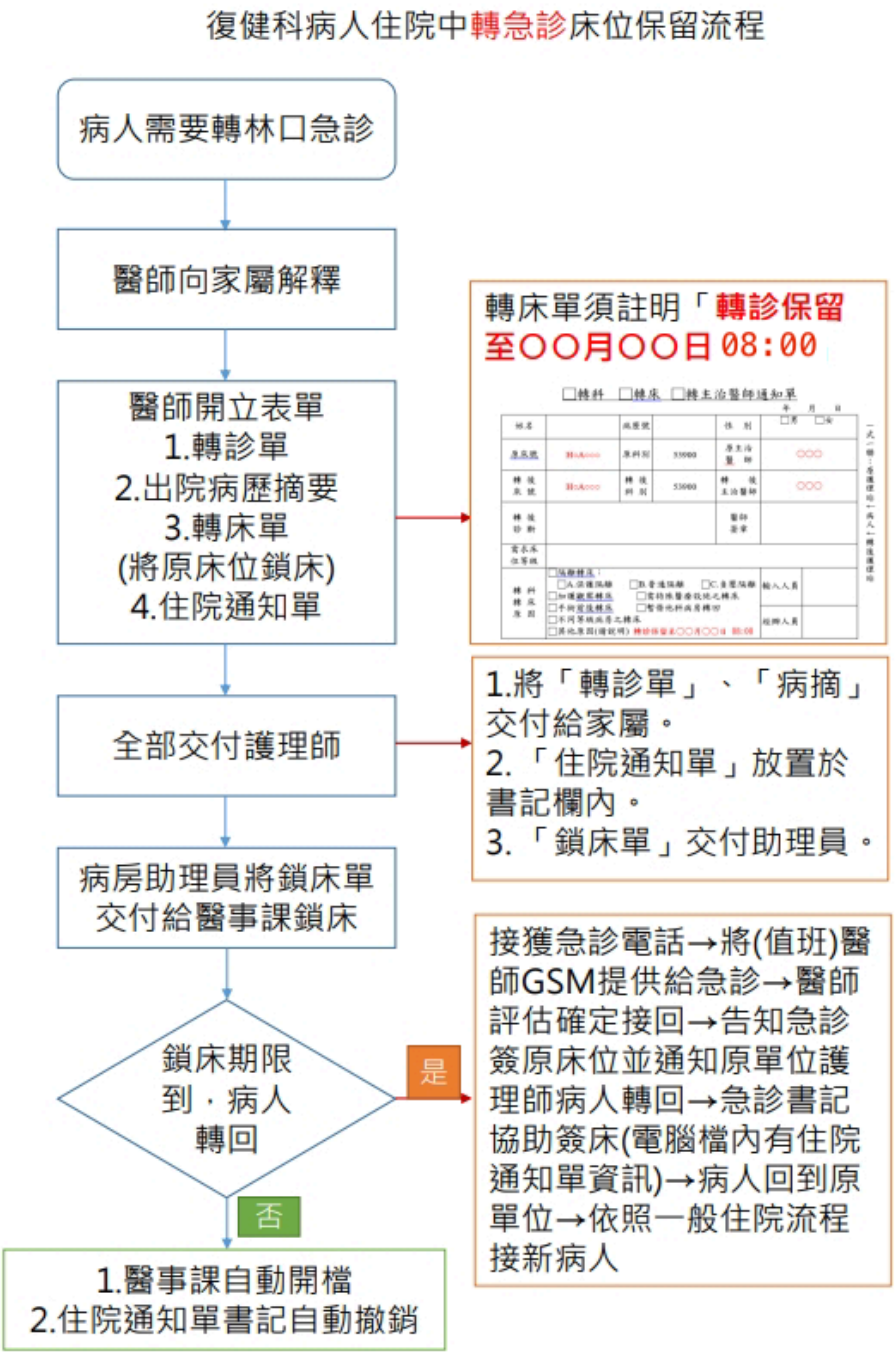
✔ 送急診的當天不能結帳 (暫繳款), 家屬需要再回來一趟, 回來的時候也不能拿診斷書, 請他們回門診開！(如果家屬很堅持要拿到診斷書, 我們的做法是只寫原本的診斷如腦中風, 不寫轉去的急性事件如敗血性休克)

(3) 在轉急診前, 須先跟病人及家屬解釋, 轉送後若沒事或是後續病情穩定, 不需收入林口病房, 則會有以下幾種動向:

✔ 直接從急診出院, 後續回主治醫師門診評估

✔ 特殊狀況:若當科主治醫師同意, 可由急診直接轉回我們的病房或開單等床, 但兩次住院天數需合併計算--->沒遇過, 但最近開會靖倫主任表示若是同一天且仍有空床就可以轉回, 且可以直接打給主治醫師確認。

★ 不管病人是否被收治入院, 若後續動向是從林口直接回來復健科時, 須注意其間隔是否大於14天, 否則兩次住院天數需合併計算



- 值班：無論如何，任何時刻，一定要至少有一位醫師位於桃園院區，讓護理站能夠找到人。絕對不能鬧空城。

  ★ 若NP team有病人有問題，可幫忙一起討論與處理。因為一天24小時中，除了白班8小時以外，其他16小時也是值班R1處理，67%是由我們承擔後果。

1、 白班與值班的切點為16:30，接新病人切點為16:00(以護理紀錄為主，上系統但可能人還沒上來；最近多次發生白班護理師忘記teamplus或打電話告知有新病人入院，導致值班人員被摳要接16:00前病人的狀況，請大家互相協調幫忙)（16:00的切點可以由R1們彼此協調和更動，唯記得須先告知3A,5A護理站）

2、 PM off:看同屆協調如何cover，下班前記得找同屆交班完成，還有確認是否有New Pa要接，11:00前（以護理站報到時間為準）來的new Pa要記得接完才能走～否則沒有order，護理師很難辦事

3、 值班接Pa打admission note:目前假日值班進Pa數已有管制，3A +5A 6床，平日16;00之後沒有數量限制，應該不會遇到以下狀況，但之後可能會調整，所以還是放上來參考

(1) 1-7全部完成

(2) 8-10選三床打，其餘當科完成

(3) >11全不打，其餘當科完成

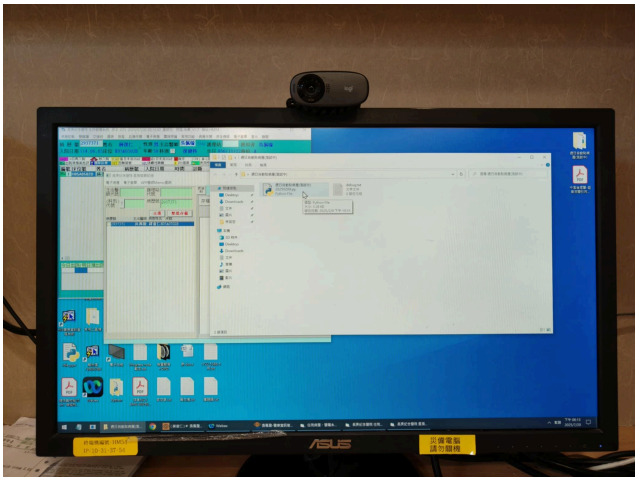
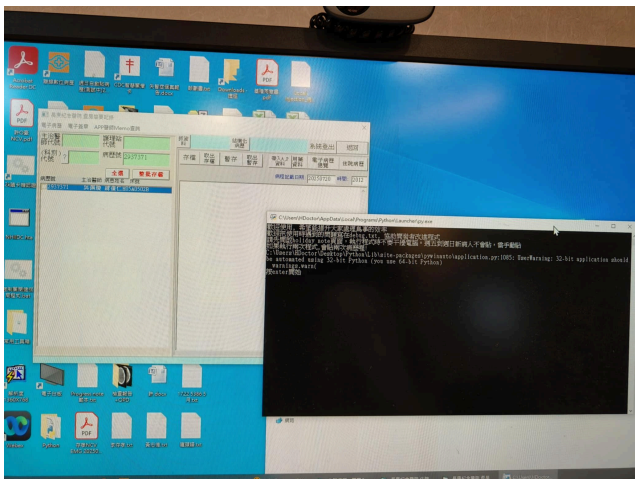
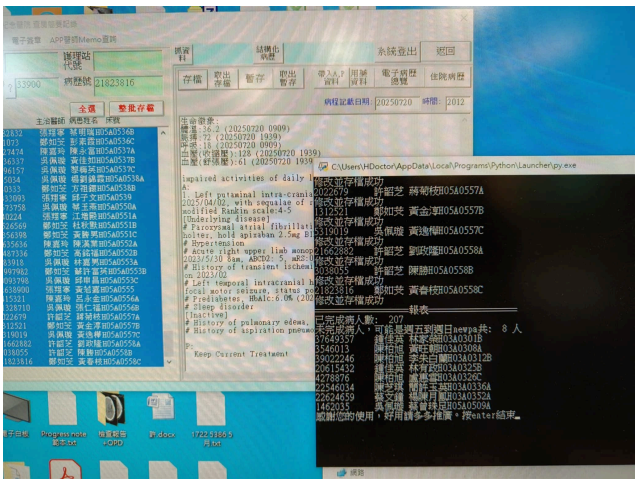
★ 平日沒有上限，所以如果當天值班cover off同事的new胚，就有機會超過6床，不過我們這一屆note還是值班全吃，大家可以同一屆自己討論

4、 On duty note:值班時病人有狀況，一定要記得打Duty note[有些VS(如 芝琪)要求fever要有note]，且隔天口頭與當科交班或傳在群組

5、 星期六值班:中午12點以前至OT教室，清點急救車

6、 星期日病歷:桃園請R1值班人員以當天值班的VS帳號完成holiday note

★ 五樓的最內一台電腦(佩璇位)有個小程式，僅支援舊版HIS系統。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>登入值班VS帳號> 病歷記載>progress note>holiday note</td><td>跳出holiday note小方框後點回桌面右上角"周日自動點病歷”</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Enter開始後電腦會自己往下點 “只能按一次enter” “開始之後請不要干擾到電腦”	最後黑框中會跳出沒被完成到的病歷號，需手動貼上診斷與主訴改成「impaired activities of daily living function, 再按存檔

★ 桃分值班主治為G2、林口為H2，帳密請見line交班群組

★ 星期日病歷請「下午」2-3點過後再打！！！因為主治醫師需要在24小時內完成簽章，請不要壓榨他們的時間，不然會被通緝！

★ 國定假日值班也要打holiday note喔，忘記了就要手打220份。另外，因為是舊版HIS系統，只能用桌機簽章，但國定連假主治醫師不會來醫院，靖倫有被提醒過，目前無解...

7、 在桃分，由復健與中醫輪流協助ICU或急診轉送病人回林口，ICU或急診會打電話聯絡我們的醫師，出發前要記得告知上線，並與nurse或EMT確認要把我們載回來

8、 如果不幸遇到困難插管，困難插管流程：

(1) 醫師至少嘗試插管一次後 - 啟動困難插管流程，請助理員去ICU借pentax Airway Scope

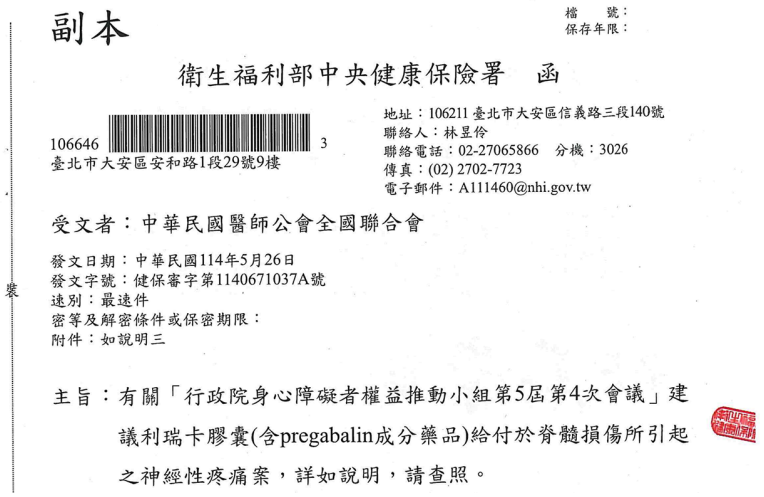
(2) 白班：麻醉科 (GSM：39553, 分機：2729、2730) - 耳鼻喉科急氣切on call VS

(3) 值班：內科值班醫師 - 桃分急診

9、之前5樓阿長鼓勵(?)大家值班遇到緊急狀況不吝於call 999，因為我們護理人力不足.....

其他

- 密碼們:林口男值密碼:0093;林口女值密碼:3846;桃分男、女值:只能用識別證;林口肌電圖室:3390
- 自費藥物開立,若有健保適應症才可健保使用:
  1、 Clopidogrel:若為DAPT,最好問清楚神內要用多久,並附註於藥物備註欄
  2、 Gabapentin / pregabalin:若病人有神經痛可考慮開立,但若要開pregabalin,要選擇「PREGABALIN」(全大寫的這個,小寫要專科才開的了~),SCI的神經痛可健保開立(有些老闆會問,請送他衛服部公文,其他要詢問老闆是否符合健保適應症->幾乎都不會符合



副本

檔　號:
保存年限:

衛生福利部中央健康保險署　函

106646 臺北市大安區安和路1段29號9樓

地址:106211 臺北市大安區信義路三段140號
聯絡人:林昱伶
聯絡電話:02-27065866　分機:3026
傳真:(02) 2702-7723
電子郵件:A111460@nhi.gov.tw

受文者:中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期:中華民國114年5月26日
發文字號:健保審字第1140671037A號
速別:最速件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如說明三

主旨:有關「行政院身心障礙者權益推動小組第5屆第4次會議」建議利瑞卡膠囊(含pregabalin成分藥品)給付於脊髓損傷所引起之神經性疼痛案,詳如說明,請查照。

  3、 PPI:四個月內沒有做過胃鏡者要自費
  4、 Cox-2 inhibitor NSAID:celecoxib、etoricoxib,一定年齡段以上可開立健保,一樣請和老闆確認一下
  5、 痠痛貼布 (flurbiprofen)、痠痛藥膏 (Rheumon gel):健保開立時不能同時與NSAID口服藥或外用NSAID製劑並存,貼布一週可一包,藥膏一個月可一條

     ★ 若病人7/10有用過ibuprofen,7/24可否開立痠痛貼布,「可以」

     ★ 若病人7/10有用過ibuprofen,7/24可否開立痠痛藥膏,「不可以」,需自費。若想開立健保藥膏,需要8/10後方可開立
  6、 Alpha-blocker:tamsulosin、silodosin等,女生及太年輕的男性(預期沒有BPH)皆需要自費

- 其餘檢查們,林口在醫師使用電腦的那邊,復健卡櫃的側面有貼一張紙,桃分有遇到再看:
  1、 UDS (urodynamic study):
     (1) 林口:泌尿科檢查 S44-101 ~ S44-104
     (2) 桃分:復健科檢查(醫藥囑都有模組)以SCI clear可以配合優先
        a. 安排流程:先告知CR,確認排程由當team醫師依據U/A結果判定是否可執行,做完後請密切觀察個案狀況(尤其是高位SCI患者,注意AD)(目前沒有人做...

2、 EMG/NCV：排程方面，林口由總醫師協助安排，詳情遇到再來問；桃分請書記排。

(1) 上肢: M29-032-N ; M29-036-N ; M29-042-N ; M29-046-N

(2) 下肢: M29-037-N ; M29-042-N ; M29-043-N ; M29-047-N

如果預計要做兩個部位以上，要請書記佔兩個時段

3、 Soft tissue echo

(1) 醫囑：Soft tissue echo（S46-202-N)

(2) 林口：由總醫師協助安排

桃分：請書記排

如果預計要做兩個部位以上，要請書記佔兩個時段

4、 Cardiopulmonary exercise test (CPET)

(1) 林口：開立order後印出同意書，再打電話給心肺檢查室7AB (2-403-5156)確認排程

(2) 桃園：有適合個案可告知CR，確認後開立order及同意書

5、 開立機器手

1. 文字Order : 開立 ".arrange 智能輔助職能治療-上肢 自費使用"
2. 開立醫囑 "S51-006" Robotic assisted occupational therapy
3. 存檔，務必點選列印自費同意書 (紙本不會印出)
4. 輸入帳號密碼，插入醫事人員卡
5. 功能選單-病歷記載-同意書-同意書開立: 點選右下角治療同意書
6. 治療原因: "肢體功能障礙" 治療名稱: "智能輔助職能治療-上肢"
7. 務必點選 "全選" 與 "同說明醫師"。 "同說明醫師" "同說明醫師"
8. 輸入 PIN 碼 存檔列印 (紙本不會印出)
9. ***開立轉介單 兩處蓋章***
10. 有一張要手填的轉介單要給護理師（請助理員轉送至2F）
11. 請追蹤病人是否同意書 (自費+治療) 簽署完成

6、 開立機器腳

1. 文字Order : 開立 ".arrange 機器人步態訓練 自費使用"

2. 開立醫囑 "S51-010" Robotic Locomotion Physical Therapy ，數量:1，存檔

4. 功能選單-病歷記載-同意書-同意書開立: 點選右下角治療同意書

5. 治療原因: "肢體功能障礙" 治療名稱: "機器人步態訓練"

6.務必點選 "全選" 與 "同說明醫師"。 "同說明醫師" "同說明醫師"

7. 插入醫事人員卡，輸入PIN 碼，存檔列印 (紙本不會印出)

8. 請印出醫囑單 ".arrange 機器人步態訓練 自費使用" 印出並送到2F

9. 請追蹤病人是否同意書 (治療) 簽署完成

★ 目前因應不同機器，有兩種自費價位，3600元和6000元，但系統自動帶入的價位是4000元，遇到比較在意價錢的家屬，這部分要稍微注意

7、 rTMS

(1) 功能選單-病歷記載-同意書-同意書開立: 點選右下角治療同意書

(2) 治療原因: "肢體功能障礙"/"認知功能障礙"，治療名稱: "重複性經顱磁刺激"

(3) 務必點選 "全選" 與 "同說明醫師"。 "同說明醫師" "同說明醫師"

(4) 插入醫事人員卡，輸入 PIN 碼，存檔列印 (紙本不會印出)

(5) 開立醫囑 M28-280-N "repetitive transcranial magnetic stimulation"，數量:通常是 2 (問主治醫師打幾個位置)，自費，備註:(日期*數量 計價Dr xxxx)，當日有做才開order>>存檔，務必點選列印自費同意書 (紙本不會印出)

★ 各類同意書或診斷書，NP都不能開立，尤其5A，如果NP請你開治療同意書、診斷書，不要覺得奇怪，就是你要幫忙開(~~等等，我不認識這個病患啊~~)

=> 陳靖倫醫師rTMS : VS會自己開所有醫囑，不須我們處理;

=> 其他 team要自己開

8、 自費治療-音樂/藝術/舞蹈治療

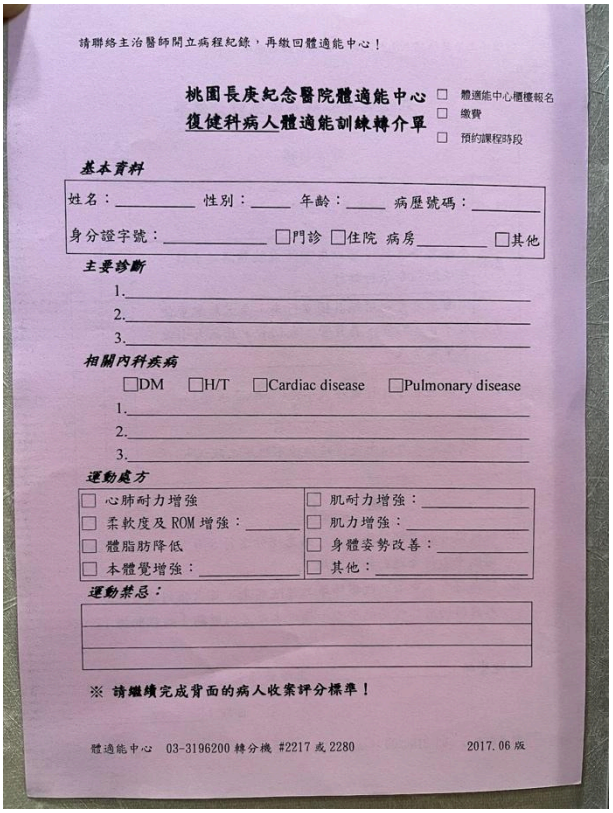
(1) 醫囑:.(JOD240)，備註:開立音樂/藝術/舞蹈治療

(2) 拿一張復健卡，把標題"物理/職能/語言"改成"音樂/藝術/舞蹈"，貼上一張progress note，放到護理站中間桌上(助理員會送下去對應地點)

9、 自費治療-體適能訓練

(1) 醫囑:.(JOD240), 備註:開立體適能訓練

(2) 填寫「體適能訓練轉介單」, 背面表格全部都要0分



請聯絡主治醫師開立病程紀錄，再繳回體適能中心！

桃園長庚紀念醫院體適能中心 ☐ 體適能中心櫃檯報名
復健科病人體適能訓練轉介單 ☐ 繳費
☐ 預約課程時段

基本資料

姓名：_____ 性別：_____ 年齡：_____ 病歷號碼：_____

身分證字號：_____ ☐門診 ☐住院 病房_____ ☐其他

主要診斷

1._____
2._____
3._____

相關內科疾病

☐DM ☐H/T ☐Cardiac disease ☐Pulmonary disease

1._____
2._____
3._____

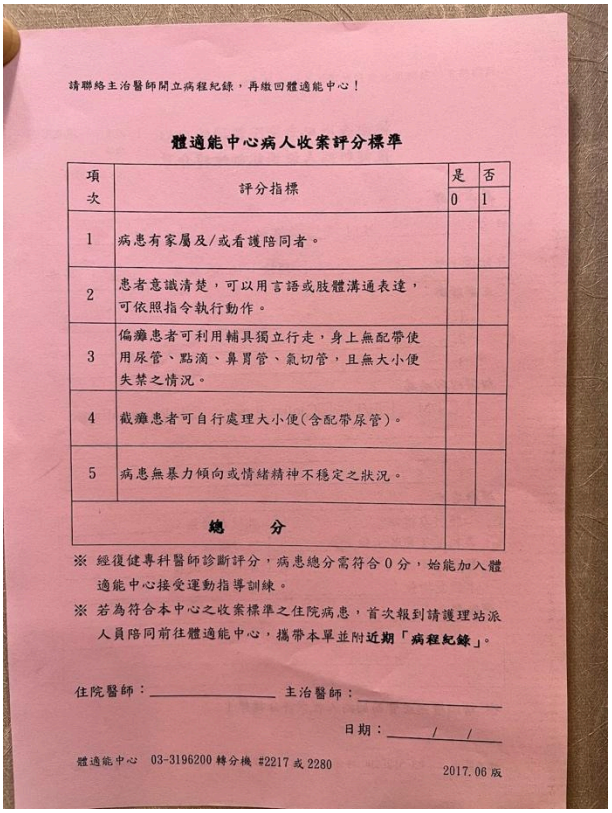
運動處方

☐ 心肺耐力增強	☐ 肌耐力增強：_____
☐ 柔軟度及 ROM 增強：_____	☐ 肌力增強：_____
☐ 體脂肪降低	☐ 身體姿勢改善：_____
☐ 本體覺增強：_____	☐ 其他：_____

運動禁忌：

※ 請繼續完成背面的病人收案評分標準！

體適能中心 03-3196200 轉分機 #2217 或 2280 2017.06 版



請聯絡主治醫師開立病程紀錄，再繳回體適能中心！

體適能中心病人收案評分標準

項次	評分指標	是 0	否 1
1	病患有家屬及/或看護陪同者。		
2	患者意識清楚，可以用言語或肢體溝通表達，可依照指令執行動作。		
3	偏癱患者可利用輔具獨立行走，身上無配帶使用尿管、點滴、鼻胃管、氣切管，且無大小便失禁之情況。		
4	截癱患者可自行處理大小便(含配帶尿管)。		
5	病患無暴力傾向或情緒精神不穩定之狀況。		
	總 分		

※ 經復健專科醫師診斷評分，病患總分需符合 0 分，始能加入體適能中心接受運動指導訓練。

※ 若為符合本中心之收案標準之住院病患，首次報到請護理站派人員陪同前往體適能中心，攜帶本單並附近期「病程紀錄」。

住院醫師：_____ 主治醫師：_____

日期：____/____/____

體適能中心 03-3196200 轉分機 #2217 或 2280 2017.06 版

(3) 拿給護理師(會請助理員送到體適能治療中心)

9 、IV Laser

(1) 醫囑:Intravascular Laser Irradiation(S51-993)

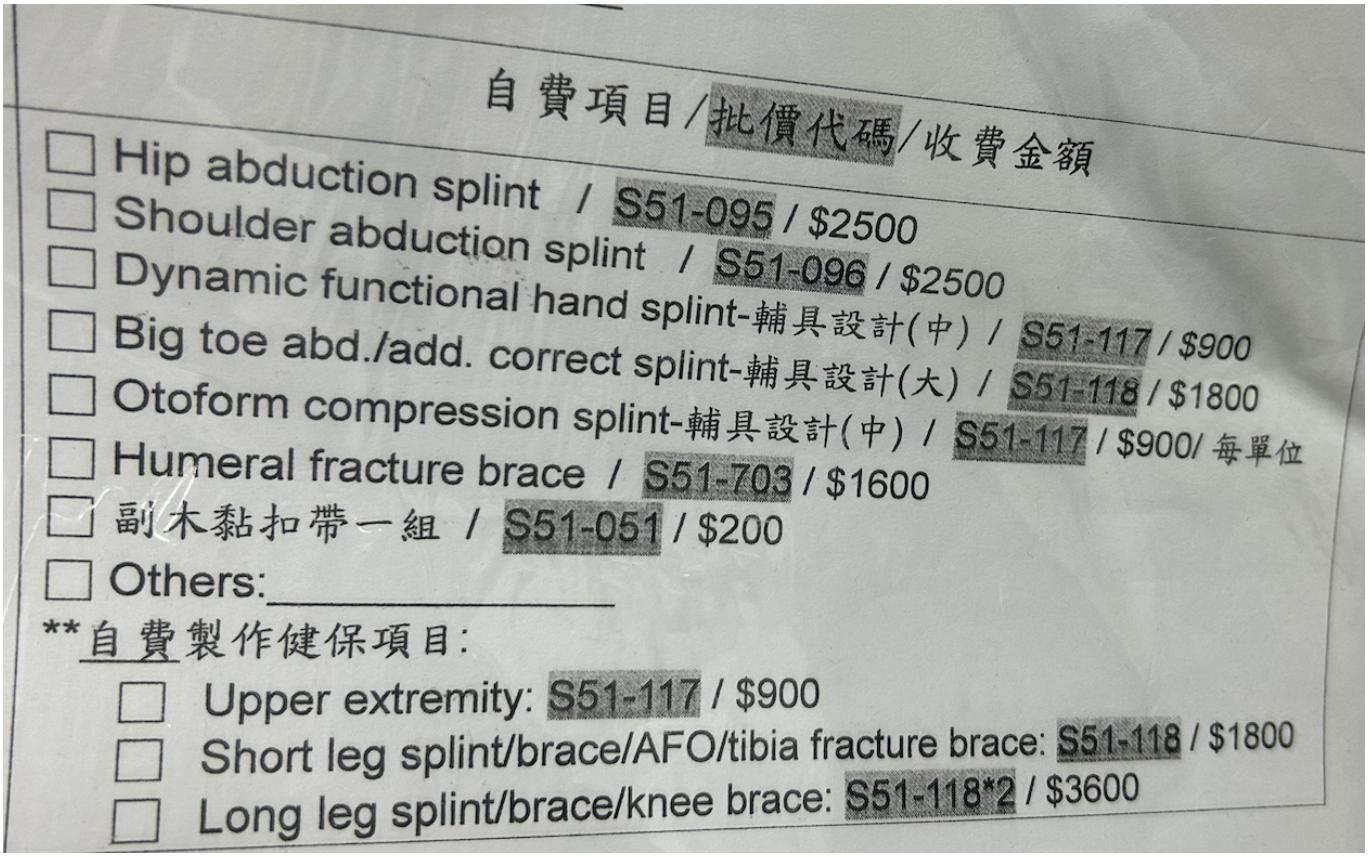
(2) 2026/07科會討論結果是現行住院中的病人由靖倫醫師繼續執行業務, 包括安排時程＋開立醫囑, 之後要新增的個案將由各主治醫師自行安排＋執行

10 、副木批價代碼

(1) 健保醫囑:OT OTHERS(ROT17), 備註:部位和種類

(2) 自費醫囑:詳見以下表格, 備註:部位和種類;使用時機:6個月內做同一隻肢體的副木要自費, 最常用到的是最下面三個。

我怎麼知道有沒有6個月內 (問不到就要土法煉鋼刷醫囑紀錄...)



自費項目/批價代碼/收費金額

☐ Hip abduction splint / S51-095 / $2500
☐ Shoulder abduction splint / S51-096 / $2500
☐ Dynamic functional hand splint-輔具設計(中) / S51-117 / $900
☐ Big toe abd./add. correct splint-輔具設計(大) / S51-118 / $1800
☐ Otoform compression splint-輔具設計(中) / S51-117 / $900/ 每單位
☐ Humeral fracture brace / S51-703 / $1600
☐ 副木黏扣帶一組 / S51-051 / $200
☐ Others:_____
**自費製作健保項目:
☐ Upper extremity: S51-117 / $900
☐ Short leg splint/brace/AFO/tibia fracture brace: S51-118 / $1800
☐ Long leg splint/brace/knee brace: S51-118*2 / $3600

- 巴氏量表

  是政府用來判斷病患是否已失能、是否需要外籍看護的標準。開立時間普遍是發病後六個月，因為會來到我們復健病房的病人，就表示有復健潛能，在六個月內狀況都還會進步，太早開就會不符合實際狀況；不過書群醫師會視情況提早開立。

  若病患發病滿六個月，家屬來詢問是否可以開立：

  (1) 初步評估是否符合資格

  ★ 年滿80歲以上：無條件可開立。

  ★ 未滿80歲：Barthel index 小於35分才有機會。

  （桃分接new胚時，家屬很常會第一次剛從林口或是外院過來就要求寫，沒超過六個月，

  如果是當科，基本上可以先說明六個月的原則，有疑慮請洽主治醫師）

(2) 若初步符合資格，就請家屬到勞動部網站下載，或是向外籍看護的仲介公司索取「病症暨失能診斷證明書」和「申請聘僱外籍看護工基本資料傳遞單」

★ 請提醒他們一定要是最新版本，「病症暨失能診斷證明書」是112 年 10 月 13 日修訂，「申請聘僱外籍看護工基本資料傳遞單」是11501版

★ 一共五頁，請他們單頁列印，裝訂並填好第一頁的基本資料、貼上3 個月內的照片，後面兩頁的姓名及申請人資料也要寫好再交給我們（不要貼看起來很健康的照片！資料沒填好，請直接退換給家屬）

★ 申請日期請家屬不要填寫

(3) 拿給主治醫師填寫，只要寫過字的地方都要蓋主治醫師的章

★ 病名和醫師囑言處文字比較長，多蓋幾次醫師章

★ 貼照片的地方要蓋騎縫章

★ 每一張和下一張也都要蓋騎縫章，總共4次

(4) 拿給R3以上職級的人簽名和蓋章

★ 總共要蓋5處：第一頁（貼照片處騎縫章、最下面）、第二頁最下面、第三頁最下面、第四頁醫療團隊章處

★ 最後要再確認資料填妥、該蓋的印章，以及所有日期是一致的

(5) 一般保險用：直接還給家屬
申請外籍看護用：交還給家屬以外，記得開立醫囑：JOD056外籍監護工申請證明書

★ 如果是申請外籍看護用，通常可以放在護理站桌上，由護理師協助交還給家屬，後續家屬要拿下去住輔中心跑醫院端的流程，之後統一送件，再由區公所通知是否申請通過。所以家屬若問申請進度，請他們打給區公所詢問。

- 身心障礙者鑑定表

就是申請殘障手冊，一樣是發病後六個月可以開立，最初步的評估是單側、上或下肢的muscle power小於等於3分，才有機會開到輕度的殘障手冊。初步評估沒問題的話，請家屬至區公所領取手冊（會是像一本書一樣的裝訂），填寫好基本資料後，拿給主治醫師簽署，簽完之後一樣拿主治醫師的印章把所有寫過字的地方蓋章，再開立醫囑：JOD057身心功能鑑定，連同order單和鑑定表拿給護理站，書記會協助約社工進行身心評估，完成評估後，社工會將報告送至衛生局，大約一個半月後會審核完成，再請家屬到區公所拿殘障手冊。（一定記得開order，不然會衝康主治醫師喔～）